

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Не просто накормить

Как организовать безопасное, достойное и вариативное питание людей с психическими нарушениями в домах социального обслуживания

От единого меню к поддерживаемому выбору: здоровье, безопасность, права жителей, организация пищеблока, деньги и ответственность руководителя

Санкт-Петербург · 25–27 августа 2026 года

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Для руководителей стационарных организаций социального обслуживания из 51 субъекта Российской Федерации

Чистяков Е. В., директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“»

Содержание

1. Титульный лист	3
2. Введение	4
3. Аннотация	5
4. Резюме для руководителя	6
5. Постановка задачи: стол, контингент, критерии «накормить»	8
6. Лестница моделей вариативности	11
7. Пищевое поведение при психических расстройствах	13
8. Дисфагия и аспирационный риск	15
9. Лекарства и еда: правила для кухни	18
10. Риски пищевого поведения: отказ, гиперфагия, пикацизм	20
11. Невербальный выбор	23
12. Дееспособность, опека и выбор еды	25
13. Право Российской Федерации: разрешено, требуется, недопустимо	27
14. Санитария и пищевая безопасность при вариативности	30
15. Технология: пары блюд, раздача, журнал выбора	32
16. Аудит и замеры	35
17. Контекст: география системы и региональные нормы	37
18. Российские практики: подтверждённые кейсы и региональная модель	39
19. Международные ориентиры и границы переноса	42
20. Доказательные вмешательства и их границы	44
21. Персонал стола и совет жителей	46
22. Финансы и закупки	49
23. Документы, проверка и ответственность руководителя	51
24. Пилот на 90 дней и дорожная карта на 12 месяцев	54
25. Возражения и ответы	57
26. Контур выше учреждения: учредитель и отрасль	59
27. Достоверность и ограничения	61
28. Аутсорсинг питания: контракт как место вариативности	62
29. Заключение	64
30. Источники	65

1. Титульный лист

Как организовать безопасное, достойное и вариативное питание людей с психическими расстройствами в домах социального обслуживания

Научно-методическое издание (компактная редакция) к межрегиональному методическому семинару-совещанию «Пространство Новых Идей 2.0»

Автор: Чистяков Евгений Владимирович, директор Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Дом социального обслуживания „Серафимовский“»

Со-модератор дискуссии: Нурбаев Тимур Аликович, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Дом социального обслуживания „Тесовый берег“»

Тема семинара: «Права, свободы, интересы жителей и персонала социальных стационаров»

Дискуссия «Организация питания: опыт реализации проектов» — 26 августа 2026 года, площадка № 2, ДСО «Тесовый берег». Санкт-Петербург, 25–27 августа 2026 года.

Организаторы: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга.

Аудитория: руководители стационарных организаций социального обслуживания — психоневрологических интернатов и домов социального обслуживания — из 51 субъекта Российской Федерации.

Документ не является нормативным правовым актом, клиническим руководством или индивидуальной юридической консультацией. Локальные формы, приводимые в связанных материалах, — проекты и требуют адаптации. Ограничения доказательной базы — раздел 41.

2. Введение

Организация питания в стационарной организации социального обслуживания одновременно затрагивает безопасность, достоинство проживающего, лекарственно-пищевые ограничения, кадровый ресурс и документальное оформление. Типовые конфликты одного обеда — очередь против помощи, отказ без журнала, кофеин при терапии клозапином, «добавка» без врача, журналы, заполняемые «к комиссии», — образуют единую систему: недоедание и пищевые отходы связаны. Национальной доли отходов для отрасли нет; её даёт семидневный замер в конкретной организации. Распространённость дисфагии в изученных клинических группах составляет 21,9–69,5 %; перенос этого диапазона на все российские ДСО некорректен¹.

Решение о составе тарелки принимают проживающий, персонал ухода, врач, кухня, условия контракта или региональная норма. Эмпирически чаще доминируют «кухня» и «норма», реже — выбор проживающего. Для проживающего приём пищи — три–четыре события суток; реализация прав либо доходит до тарелки, либо остаётся декларацией.

Клинические решения не назначает кухня. Таблица «лекарство × еда», текстуры, «диабетический стол», действия при отказе от еды — зона врача (раздел 4.0).

Публично подтверждены практики Новосибирской области, Усть-Илимска и ДСО «Серафимовский»; Иркутская область масштабирует выбор на регион^{2, 3, 4, 5, 6}.

По данным за 2024 год, обработанным проектом «Если быть точным», порядка трёх из четырёх жителей ПНИ признаны судом недееспособными⁷. Цифра конкретного учреждения будет иной; логика та же: повседневное пищевое предпочтение, как правило, не является сделкой; опекун учитывает мнение подопечного (ст. 29 ГК РФ).

3. Аннотация

Научно-методическое издание по организации питания в стационарных организациях социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами (психоневрологические интернаты и дома социального обслуживания). Подготовлено к семинару «Пространство Новых Идей 2.0» (Санкт-Петербург, 25–27 августа 2026 года). Автор — Чистяков Е. В., директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“». Адресат — руководители таких организаций.

Рассматриваются три группы вопросов. **Клинические:** отличие кормления лиц с психическими расстройствами от типового стационарного питания; лекарственно-пищевые взаимодействия; метаболические эффекты антипсихотиков; дисфагия и аспирация; расстройства пищевого поведения — с разграничением компетенции врача и кухни. **Правовые:** пределы дозволенного и обязательного в части выбора блюд; документальное оформление вариативного питания. **Управленческие:** пилот на 90 дней, замер исходного состояния, согласование с учредителем.

Доказательная база: российское право и публичные практики, клинические публикации, международные ориентиры — со сносками в тексте и перечнем в разделе 44. Подтверждены четыре российские публичные практики (Новосибирская и Иркутская области, Санкт-Петербург, 2024–2025); Иркутская область масштабирует выбор на региональном уровне.

Объём настоящего издания — основной текст со списком источников. Учебные кейсы и проекты локальных форм публикуются в семинарском пакете отдельно.

4. Резюме для руководителя

Краткий маршрут: собирательная ситуация (раздел 5), граница компетенции (4.0), выводы 2, 5, 7, 10 и минимальная модель (4.4). Анализ начинается с несъеденного и голода, затем — документальный контур и пилот на одном отделении.

4.0. Граница компетенции кухни

Без врача: любые ограничения рациона (включая «диабетический стол»), изменение текстур, правила при дисфагии и протокол свободной воды, действия при длительном отказе от еды, режим питания при седации, решения об энтеральном/зондовом питании и о комфортном кормлении в конце жизни, сдвиг времени еды у жителей на инсулине, слабительные и реакция на запор, назначение анализов и добавок микронутриентов, интерпретация MUST и витаминизация при ОРИ.

Без учредителя: изменение финансирования продуктовой строки, штатного расписания (норма помощи за столом), аутсорсинг питания, официальный статус и публичность пилота.

Без правовой проверки: формулировки о «согласии недееспособного» в локальных актах, обработка пищевых карт как персональных данных, ответы на запросы прокуратуры, конструкции, где учреждение одновременно является опекуном жителя.

Таблица «лекарство × еда» на посту законна только с подписью врача. Кухня исполняет назначение, не ставит диагноз.

4.0а. Классы утверждений

Норма. Цитата закона с реквизитами и датой проверки.

Толкование. Системное прочтение нормы в ситуации, которую она прямо не регулирует; не выдавать за прямой запрет или прямое разрешение.

Рекомендация. Опыт конкретного дома или региона; не норма.

Проект локальной формы. Шаблоны — черновики; каждый требует адаптации.

Источники проверены 23.07.2026; правовая сверка — 19–21.08.2026. С 01.09.2026 действует СанПиН 2.3/2.4.4282-26. Ограничения — раздел 41.

4.1. Основные выводы

1. Ошибки за столом проверяют как юридически значимые. Проживающие в ПНИ и ДСО для лиц с психическими расстройствами пользуются правами пациентов психиатрических стационаров (ст. 43 Закона № 3185-1). Питание нормировано СанПиН 2.3/2.4.3590-20; с 01.09.2026 — СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 56 подп. 11^{8, 9}. Дела по ст. 6.6 КоАП касаются качества и достаточности, не числа вариантов блюд¹⁰.

2. Ответ проверяющему — комплект документов. Федеральное право не запрещает вариативность и не обязывает давать выбор каждого блюда. Таблицы замены в раскладках —

законный механизм^{11, 12}. Минимальный комплект: положение, меню с вариантами, журнал заказа, журнал замен, пищевые карты, согласование с учредителем. Публичные практики: два ПНИ Новосибирской области, Усть-Илимск, Серафимовский; Иркутская область масштабирует на регион^{2, 3, 4, 5, 6}.

3. Основные риски стола — клинические. Антипсихотики различаются по прибавке веса (мета-анализ 100 РКИ: от -0,23 кг до +3,01 кг за 6 недель)¹³. Распространённость дисфагии в отдельных изученных группах — 21,9–69,5 %; перенос на все российские ДСО некорректен¹. Смертность от пневмонии при тяжёлых психических расстройствах в семь раз выше популяционной¹⁴.

4. Четыре лекарственно-пищевых правила исполняются по таблице врача: клозапин – кофеин, литий – соль и вода, ИМАО – тирамин, карбамазепин – грейпфрут^{15, 16, 17, 18}.

5. По агрегированным данным о российских ПНИ за 2024 год порядка трёх из четырёх признаны судом недееспособными (74 %; проект «Если быть точным», публикация 09.04.2026)⁷. Сделки совершает опекун (ст. 29 ГК РФ). Повседневное предпочтение, как правило, не сделка; мнение недееспособного обязаны выяснять и учитывать.

6. Жёсткие ограничения рациона — зона врача. Приказы Минздрава о лечебном питании адресованы медицинским организациям и не распространяются на СОСО автоматически^{19, 20}.

7. Вариативность без журналов — имитация.

8. Финансовая модель начинается с замера отходов и трудозатрат.

9. Директор отвечает за систему контроля, а не за каждое отдельное событие^{10, 21}.

10. Пилот на 90 дней на одном отделении обычно укладывается в текущую смету^{2, 3}; полный переход дома может потребовать оборудования и ставок⁵.

11. Лечебное питание и вариативное меню совместимы, если диета задаёт множество блюд, а не одно. Серафимовский — 223-ФЗ, Тесовый берег — 44-ФЗ.

4.6. Маршруты чтения

Руководитель: разделы 4, 5, 8, 22, 35, 37, 42. **Внедрение:** 6–8, 17–19, 31, 35–36. **Обоснование:** 23–27, 37, 39, 41.

5. Постановка задачи: стол, контингент, критерии «накормить»

Учебный кейс, составленный для анализа. Все персонажи и совпадения вымышлены; ситуация собрана из типичных элементов, описанных в проверенных источниках и практиках учреждений.

СИТУАЦИЯ: ОБЕД, КАК ОН ЕСТЬ

Средний по России психоневрологический интернат — 289 коек⁷. Обеденный зал на 120 мест, поточная раздача в три захода²². На линии — один вариант каждого блюда: борщ, гречка с котлетой, компот. Двенадцать жителей первого захода едят только с помощью. На смене — четыре сиделки, из которых одна развозит лекарства. До конца смены — пять часов.

Первый конфликт: очередь против помощи. Самостоятельные жители получают порции первыми и едят остывшее. Нуждающиеся в помощи ждут: четыре сиделки на двенадцать кормимых — не менее трёх циклов по 15–20 минут. Последние получают холодную еду. Международная норма (раздел 26) требует не более двух полностью кормимых на одного работника и подачи еды только при готовой помощи²³; в российском праве это не закреплено, однако здесь формируются недоедание и аспирация «на скорость».

Второй конфликт: «он опять не ест кашу». Житель С. третий день отодвигает тарелку. Сиделка записывает в тетрадь — или не записывает: формы журнала отказов нет, врач узнаёт об отказах на обходе в четверг. У С. депрессивный эпизод и, возможно, начинающаяся дисфагия; логопеда в штате нет, признаки расстройства глотания (покашливание, «влажный» голос после еды) не связываются с отказами²⁴. Отказ интерпретируется как «каприз» или «симптом» в зависимости от дежурного.

Третий конфликт: лекарства и кофе. Житель К. на клозапине с утра выпил две большие кружки крепкого кофе, принесённого родственниками. Семья и житель не предупреждены о взаимодействии кофеина с клозапином: при резком увеличении потребления кофеина описаны клинически значимые росты концентрации препарата^{15, 25}. Вечером седация сильнее обычного — списывается на «плохой день».

Четвёртый конфликт: добавка. Житель П. на оланзапине набрал за год 14 килограммов — мета-анализы фиксируют выраженный весогенный профиль оланзапина¹³. П. просит вторую котлету. Сиделка отказывает — «вам нельзя, вы полнеете». Врачебного назначения ограничения рациона нет: решение принято сиделкой. П. обижается, вечером забирает хлеб у соседа. Конфликт квалифицируется как «нарушение дисциплины», а не как результат неуполномоченного решения.

СИТУАЦИЯ: ПОЧЕМУ ВСЕ ПЯТЬ КОНФЛИКТОВ — ОДНА СИСТЕМА

Каждый конфликт имеет отдельного «виноватого» в восприятии участников и представляет собой отказ системы:

КОНТИНГЕНТ: НЕОДНОРОДНОСТЬ КАК ЕДИНСТВЕННАЯ НОРМА

Ошибка планирования питания — опора на «среднего жителя ПНИ». По агрегированным данным контингент расслаивается: 65 % жителей старше 45 лет, 74 % признаны недееспособными, 11 % — постельные или маломобильные⁷. В одной столовой одновременно: пожилой человек с шизофренией и старческой дисфагией; молодой мужчина с РАС и сенсорной невосприимчивостью текстур; женщина с аффективным расстройством и набором веса на препаратах; человек с умеренной умственной отсталостью, не читающий меню; житель в ремиссии, готовящийся к сопровождаемому проживанию.

Коммуникация. Неговорящие и малоговорящие — значимая доля контингента. Вербальный вопрос «что будете?» для них неэффективен. Международное право (Замечание общего порядка № 1 к ст. 12 КПИ) требует поддержанного, а не подменяющего принятия решений²⁶.

Соматика. Дисфагия (раздел 10), диабет и метаболический синдром (разделы 11, 13), запоры — в том числе клозапиновые²⁷, сердечно-сосудистая патология, эпилепсия. Соматическая карта определяет ограничения, внутри которых действует выбор.

Жизненный опыт и культура. Пищевые привычки, религиозные правила, якорные блюда. Немецкий стандарт требует «биографию питания» при поступлении²⁸. Форма — приложение 3.

КОНТИНГЕНТ: КЛАССИФИКАЦИЯ ДЛЯ ПРАКТИКИ

Группа	Как распознать	Главный риск за столом	Маршрут питания
Самостоятельные, стабильные	Едят сами, выражают предпочтения словом	Однообразие, «столовская» еда	Полный выбор, участие в совете жителей
Самостоятельные, нестабильные	Волнообразное состояние	Пропуски приёмов при обострении	Выбор + «особые состояния» в пищевой карте
Маломобильные	Едят в жилой зоне	Холодная еда, очередь «в последнюю очередь»	Подача под готовую помощь, контроль температуры
Нуждающиеся в кормлении	Не могут есть сами	Недоедание, аспирация «на скорость»	Норма помощи 1:2 (ориентир), медленный темп
Неговорящие / малоговорящие	Не отвечают на вопрос о выборе	Подмена выбора удобством персонала	Показ порций, наблюдение, пищевая биография
С дисфагией	Покашливание, «влажный» голос, долгий приём	Аспирация, пневмония	Назначенная текстура, поза, темп (раздел 10)
С выраженным набором веса	+5 % и более за 3 месяца на препаратах	Метаболический синдром	Мониторинг, пищевая среда, без самостоятельных «диет» (раздел 13)
С расстройствами пищевого поведения	Переедание, ночное едение, пика, заглатывание	Соматические и бытовые риски	Индивидуальные протоколы (разделы 13, 14)

КОНТИНГЕНТ: ПЯТЬ ЧИСЕЛ КОНТИНГЕНТА

До пилота фиксируются: сколько едят сами, с помощью, неговорящих, в группе дисфагического риска, на весогенных препаратах. Форма — приложение 35.

1. Достаточность. Порция по весу и составу покрывает норму: приказ Минтруда № 520н и региональные нормы^{29, 11, 12}. Измеритель — фактическое потребление; несъеденная порция достаточностью не является. Замер остатков (приложение 25) — первый инструмент.

2. Безопасность. Санитарный слой: пробы, температуры, отдельные потоки — СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (до 31.08.2026; с 01.09.2026 — СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 56 подп. 11–13, п. 62)⁹. Клинический: текстуры при дисфагии (раздел 10), лекарственно-пищевые ограничения (раздел 11). Поведенческий: защита от заглатывания, пики (раздел 14). Провал любого слоя — предмет ответственности (раздел 33)¹⁰.

3. Удовольствие. Вкус, температура, вид, разнообразие. В институциональной среде удовольствие — фактор потребления. Международные нормы связывают качество блюд с нутритивными исходами^{30, 31}. Измеритель — остатки и жалобы.

4. Социальность. Еда как совместное событие. Финская рекомендация закрепляет совместные трапезы персонала и проживающих³²; голландское РКИ семейной подачи показало рост качества жизни и потребления энергии³³. Социальность — мониторинг: работник замечает «он сегодня не жуёт» раньше журнала.

КРИТЕРИИ: МАТРИЦА ПРОВАЛОВ

Измерение	Типовой провал	Быстрый измеритель
Достаточность	Норма на бумаге, недоедание на тарелке	Доля несъеденных порций (7-дневный замер)
Безопасность	Журналы есть, контроль имитируется	Сверка фактических проб с графиком без предупреждения
Удовольствие	«Столовая» еда, однообразие	Блюда-аутсайдеры по остаткам; жалобы
Социальность	Столовая как конвейер	Наблюдение за одним обедом: есть ли разговор
Самостоятельность	Всё делают за жителя	Доля жителей, проходящих линию сами
Выбор	Решает кухня	Ответ на вопрос «что вы сегодня выбрали?»

КРИТЕРИИ: ПРОВЕРКА КАЖДОГО ИЗМЕРЕНИЯ НА ЛИНИИ

Шесть проверок по ~10 минут за один день: **безопасность** — сколько жителей из списка риска едят вне поля зрения смены; **физиология** — интервал ужин–завтрак (шведский ориентир ≤11 ч³⁰; пример: ужин 17:30 → завтрак 8:30 = 15 ч); **психология** — вопрос трём жителям вечером «что было на обед»; **социальность** — ест ли персонал с жителями; **право** — проверка реальности выбора (приложение 24); **экономика** — сырьевая строка (приложение 25).

6. Лестница моделей вариативности

8.1. Термины, чтобы не путаться

В обсуждениях смешивают четыре конструкции. **Цикличное меню** — повторяющийся цикл (14 дней по российским раскладкам, 21 день в Онтарии, 4 недели по немецкому стандарту)^{22, 23, 31}: разнообразие во времени, не выбор. **Вариативное меню** — более одного варианта блюда в одной точке приёма пищи. **Замена по таблице** — эквивалентная замена в раскладке^{11, 12}: законна, но не является выбором жителя. **Персонализация** — индивидуальные назначения вне общего выбора.

Типовая ошибка: назвать «вариативным» цикличное меню или таблицу замен. В докладе «вариативность» — реальная возможность получить не менее двух вариантов и влиять на выбор.

8.2. Лестница моделей

Модели М0–М5 — рабочие конфигурации; М1–М2 подтверждены российской практикой (Болотнинский, Успенский, Иркутск)^{2, 3, 4, 6}.

М0. Мономеню с учётом отказов. Выбора нет; отказ влечёт замену по таблице, остатки влияют на цикл. Американская норма требует альтернативу при отказе как минимум³⁴.

М1. Выбор из двух вариантов в одной позиции. Второй вариант ключевого блюда на части приёмов. Болотнинский ПНИ — «несколько раз в неделю», завтрак и обед². Цена: вторая гастрорёмкость, журнал заказа (раздел 29).

М2. Выбор по всем основным позициям ежедневно. Успенский ПНИ³, Иркутская область⁶. Требуется журнал заказа и пересчёта объёмов (раздел 21).

М3. Выбор на линии («шведский стол»). Комплектация тарелки на линии. Требования: площадь, поток, санитарный контроль⁹. ДДСОЛ²²; Успенский — М2, не М3³.

М4. Семейная подача. Общие блюда на столе. Эффект у пожилых с деменцией³³; применима точно.

М5. «Своя кухня». Жители готовят с поддержкой^{35, 36}. Горизонт квартир тренинга, не массовая модель.

8.3. Критерии реального выбора

Пять критериев (раздел 22, приложение 24):

1. **Доступность:** вариант Б существует при подходе жителя.
2. **Равноценность:** эквивалентность по питательной ценности¹¹.
3. **Информированность:** житель знает о выборе доступным способом.
4. **Уважение:** выбранное подаётся.
5. **Учёт:** выбор фиксируется и влияет на объёмы и циклы.

8.4. Определение текущей модели

На неделе фиксируется положение на лестнице: M0, M1 или M2. Российские практики — M1–M2^{2, 3, 4, 6}. При хаотичных журналах — M0; при порядке в документах — M1 на одном отделении.

8.5. Движение вниз по лестнице: тихий регресс

Регресс чаще подъёма: уход инициатора → упрощение показа меню → журнал «для проверки», выбор возвращается к кухне. Признаки: падает доля выбирающих, растёт доля «стандартных», журнал срывов пустеет. Противоядие: документ и ритм — приказ, ротация, квартальная панель (раздел 31).

8.6. Лестница участия жителя

Нумерация ступеней участия (0–5) не совпадает с моделями M0–M5: модели — технология раздачи, ступени — мера контроля над едой.

8.8. Еда как навык сопровождаемого проживания

Порядка семи тысяч человек вышли из ПНИ в программы сопровождаемого проживания⁷. Ступени 3–5 — тренировка бытового решения. Вариативное меню готовит навык для менее институциональных форм. Для большинства домов ближайший год — ступени 1–2; ступень 5 — горизонт квартир тренинга (раздел 8.2).

7. Пищевое поведение при психических расстройствах

9.1. Почему обычные правила здесь работают иначе

Стационарное питание предполагает «среднего едока»: приход вовремя, 20–30 минут за столом, сообщение о проблемах. Психические расстройства нарушают каждое допущение системно. Раздел фиксирует паттерны для предвидения; разделы 10–14 — протоколы.

Рамка: паттерн — симптом, лекарственный эффект или их комбинация, не «характер». На симптом — врач; на лекарственный эффект — врач с кухней; на организационный сбой — администрация. Дисциплинарная реакция не показана.

9.2. Паттерны и их механизмы

Снижение интереса к еде (депрессия). Еда теряет значимость; риск — тихое недоедание. Реакция: журнал потребления, триггеры веса (раздел 12); при длительном снижении — врач. Стандарты предусматривают режим «пищи по желанию» (Wunschkost)^{28, 37}.

Подозрительность к пище (психоз). Работают: запечатанная упаковка, блюдо из общего котла, выбор между порциями, доверенное лицо, приём вне столовой. Эпизоды фиксируются врачу.

Возбуждение и мания. Питание «мало и часто», finger food³⁵, отдельная комната, отложенная порция. Норма «обед с 13:00 до 13:30» неприменима^{38, 39}.

Седация. Утренние препараты делают ранний завтрак недоступным. Реакция — гибкое окно и отложенная порция^{35, 39}. «Опоздал — остался голодным» — нарушение доступности питания.

Ригидность и сенсорные особенности (РАС, умственная отсталость). Узкий круг «безопасных» блюд, чувствительность к текстуре, виду, запаху. Реакция: постепенное расширение, «безопасный» вариант в каждом приёме; сенсорные параметры в пищевой карте.

Быстрое заглатывание. Риски: аспирация, удушье, отбирание еды. Реакция: малые порции, питьё между глотками, наблюдение; протокол дисфагии (раздел 10).

Переедание и гиперфагия. Раздел 13.

Прятание и «хомячение». Причины: опыт голода, тревога, ночное едение. Реакция — легализация доступного перекуса, не изъятие.

Избирательность «всё или ничего». Учёт в карте, регулярные «опорные» блюда, парные предложения.

9.3. Что это меняет в организации стола

Три следствия. **Журнал потребления** — **диагностический инструмент** с еженедельным чтением врачом. **«Особые состояния»** — **штатный режим** в пищевой карте (приложение 3). **Гибкость по времени и месту** — **часть безопасности** и должна быть в положении о питании.

9.4. Границы раздела

Доклад не ставит диагнозов и не описывает лечения. Уровень — организация питания и наблюдения: что фиксирует смена, когда эскалация к врачу. Организация не лечит, но обязана видеть, фиксировать и передавать.

9.7. Паттерны по сменам

По обзору RESOLVE: переедание — 4,4–45 %, тяга к еде — 16,1–64 %, ночное едение — 4–30 %⁴⁰. Четыре сцены: быстрое поедание с просьбой «ещё» → гиперфагия терапии (раздел 13); прятание еды → легальный «запас»; селективность по текстуре → пары эквивалентов; еда только в комнате → право на место. Каждый эпизод — информация о механизме, не нарушение дисциплины.

8. Дисфагия и аспирационный риск

10.1. Масштаб, о котором не говорят

Расстройство глотания (дисфагия) при психических расстройствах в изученных клинических группах — 21,9–69,5 %; разброс объясняется популяциями и методами. Диапазон **нельзя переносить на все российские ДСО и ПНИ**^{1, 24}. В типовом ПНИ часто нет логопеда, скрининга и назначенных текстур; дисфагия выявляется при тяжёлой пневмонии.

Смертность от пневмонии при тяжёлых психических расстройствах в семь раз выше популяционной (RR 7,00)¹⁴. Разрыв продолжительности жизни — 15–20 лет, значимая часть связана с факторами, на которые влияет организация стола¹⁴. Дисфагия — вопрос смертности.

10.2. Откуда берётся дисфагия при психических расстройствах

Шесть механизмов:

1. **Лекарственные:** экстрапирамидные нарушения, ксеростомия, замедление глотательного рефлекса²⁴.
2. **Болезненные:** нарушение координации «жевание — глоток — дыхание».
3. **Поведенческие:** быстрое заглатывание (раздел 9).
4. **Возрастные:** 65 % жителей старше 45 лет⁷; саркопения, старческая дисфагия.
5. **Сопутствующие состояния:** инсульт, болезнь Паркинсона, деменция, эпилепсия.
6. **Стоматологические:** отсутствие зубов, плохие протезы.

Дисфагия в ПНИ — статистически ожидаемое явление; система обязана её искать.

10.3. Признаки, которые видит сиделка без логопеда

Тревожные признаки: покашливание, поперхивание; «влажный» голос после глотка; многократное проглатывание; еда «за щекой»; долгий приём; отказ от текстур при сохранном аппетите; повторные пневмонии^{24, 41}. Любой признак — врачебная оценка; несколько — коррекция подачи до выяснения.

10.4. Текстуры: система IDDSI и её измеримый эффект

IDDSI — восемь уровней (напитки 0–4, пища 3–7) с тестами (вилка, ложка, наклон)⁴². Текстуру назначает медицинский специалист. Интервенционное исследование в пяти учреждениях: соответствие текстур — с 44 % до 90 %, загущённые жидкости — с 31 % до 100 %, эффект через 6 месяцев; барьер — осведомлённость персонала⁴³. Измеритель — доля правильных текстур на тарелках (приложение 19).

10.5. Организационный пакет без логопеда

1. **Список риска** по признакам 10.3 — на посту и в кухне.
2. **Назначенные текстуры** поимённо с датой пересмотра; маркировка порций.

3. **Правила стола:** вертикальная поза, медленный темп, малые глотки, наблюдение до конца еды.
4. **Достоинство текстур:** подача, имитирующая обычные блюда⁴⁴.
5. **«Осознанный риск»:** настаивание на обычной пище — информированное решение с врачом⁴⁴.

10.6. Связка с вариативностью

Дисфагия переносит выбор внутрь назначенной текстуры: два варианта протёртого второго. В пищевой карте (приложение 3) текстура фиксируется отдельным разделом.

10.7. Жидкости: забытая половина дисфагии

По жидкостям в исследовании внедрения старт — 31 % соответствия, эффект обучения — до 100 %⁴³. Минимум: загуститель по назначениям, тест стекания, кружки с клапанами. «Просто меньше пить» — путь к обезвоживанию^{45, 46}. Загущённые напитки снижают потребление жидкости; убедительных данных о снижении респираторных осложнений при рутинном применении нет^{45, 46}.

Протокол свободной воды (Frazier): неограниченная чистая вода между приёмами после гигиены полости рта⁴⁵. Не российская норма; допуск назначает врач. Без гигиены рта протокол противопоказан.

10.8. Пакет «без логопеда»

Четыре элемента: **распознавание** — шесть признаков, инструктаж смены; **поза и темп** — 90°, подбородок вниз, 30 мин после еды без укладывания⁴¹; **текстура по назначению** — IDDSI⁴², соответствие 44→90 %⁴³; **готовность к инциденту** — алгоритм приложения 12. Пакет не лечит дисфагию, но переводит организацию из «не знаем, кто в риске» в «знаем, наблюдаем, исполняем».

10.9. Структурированный скрининг

GUSS — четыре шага, валидирован против эндоскопии⁴⁷; **EAT-10** — 10 вопросов⁴⁸. Оба требуют адаптации для психиатрического контингента; текстуру назначает врач. Шесть признаков 10.3 — для всех ежедневно; GUSS/EAT-10 — по показаниям.

10.10. Гигиена полости рта

Аспирационная пневмония — главный смертельный риск (10.1). РКИ на 366 проживающих: уход после каждого приёма пищи снизил пневмонии с 19 % до 11 %⁴⁹. Систематический обзор (van der Maarel-Wierink et al., пять публикаций): улучшение ухода **может снижать** пневмонию и связанную смертность у немощных пожилых⁵⁰. Оценка «примерно каждая десятая смерть» — узкая выборка домов ухода, не доказанный эффект для российских ПНИ.

Уход обязателен зависимым (постельные, тяжёлая умственная отсталость, седация): ~число зависимых × 2–3 мин × число приёмов. На 80 зависимых и три приёма — ~8 чел.-ч/сут.

Минимум: щётка/губка не «по запросу»; строка в обходе; обучение смены. Плохие протезы и сухость во рту — главные жалобы⁵¹.

9. Лекарства и еда: правила для кухни

11.1. Принцип раздела

Организация стационарного питания опирается на короткий перечень правил с действием для кухни, поста и меню. Классы уверенности: **(установлено)** — исследования и инструкции; **(мониторинг)** — стабильность и наблюдение; **(рекомендация)** — профессиональные предосторожности.

11.2. Правило 1. Клозапин – кофеин: считать чашки (установлено)

Кофеин ингибирует метаболизм клозапина: AUC +19 % в среднем¹⁵; при резком увеличении — токсические концентрации (случай 1796 нг/мл)²⁵. Резкая отмена — падение концентрации на 37–47 %⁵². Курение индуцирует метаболизм клозапина и оланзапина, снижая концентрации $\approx$ вдвое¹⁵.

Действия: в карте — привычное потребление кофе/чая/энергетиков; запрет резких изменений (письмо семье, приложение 32); любое изменение — врачу. Часть британской таблицы³⁵.

11.3. Правило 2. Литий – соль и вода: стабильность (мониторинг)

Концентрация лития чувствительна к водно-солевому балансу^{16, 53}. Опасные сценарии: «малосольный стол» по инициативе кухни; жара без воды; рвота/диарея; отказ от питья.

Действия: без изменений солевого режима без врача; доступ к воде гарантирован; при рвоте/диарее или жаре — врачу в тот же день; при отказе от еды и питья — эскалация раздела 12.

11.4. Правило 3. ИМАО – тирамин: разметка меню (установлено)

Неселективные ИМАО + тираминсодержащие продукты — гипертонический криз: выдержанные сыры, копчёности, соленья, брынза, пиво, квас, соевый соус^{17, 54}. Реакции — подъём давления со 160/90 до 220/115 и выше⁵⁵.

Действия: отдельная строка в меню-потребности; тираминовая разметка от врача; выбор внутри безопасного множества.

11.5. Правило 4. Грейпфрут – ряд психотропных (установлено)

Грейпфрут ингибирует CYP3A4; для карбамазепина рост AUC $\approx$ 40 %¹⁸. Зона внимания — бензодиазепины, часть антипсихотиков.

Действия: грейпфрут и сок не в закупке и меню; сезонные передачи проверяются дежурным.

11.6. Правило 5. Алкоголь и энергетики (рекомендация)

Алкоголь при психотропах исключён; правила приёма передач. Энергетики для клозапина эквивалентны резкому росту кофеина (правило 1).

11.7. Лекарственно-пищевая таблица: форма

Пять правил — в таблице (приложение 21): препарат — ограничения — действие кухни — действие поста — сообщение врачу. Заполняет и пересматривает врач; копии — пост, кухня, комната передач³⁵.

11.8. Чего в разделе нет

Перечень не исчерпывающий; полный — у врача. Кухня исполняет таблицу, не трактует инструкции. Правила задают границы, внутри которых выбор полон.

11.9. Передачи как фармакологический канал

Комната передач — неконтролируемый канал: кофе, энергетики, грейпфруты, копчёности, алкоголь. Порядок: перечень ограничений на стенде, регистрация, маркировка, выдача по режиму. Памятка родственникам (приложение 32).

11.10. Границы таблицы

Таблица — минимум организации, не полный справочник. Классы уверенности различают «установлено» и «осторожность по классу».

11.11. Три сценария из практики поста

«Добрый кофе». Клозапин + термос кофе: рост концентрации до 1796 нг/мл²⁵, AUC +19 %¹⁵. Действие: сообщение врачу, согласованный режим; резкая отмена опасна (−37–47 %⁵²).

«Солёные огурцы». Литий + солёная передача: колебания концентрации^{16, 53}. Действие: стабильность, информация врачу.

«Сок вместо воды». Грейпфрутовый сок на карбамазепине: +40 %¹⁸. Действие: исключение на уровне кухни.

10. Риски пищевого поведения: отказ, гиперфагия, пикацизм

ОТКАЗ: ПОЧЕМУ ОТКАЗ — САМАЯ ОПАСНАЯ БЫТОВАЯ СИТУАЦИЯ

Отказ от еды в ПНИ ежедневен и обрабатывается несистемно. За отказом — разные состояния: от «невкусно» до депрессии, психоза, дисфагии, соматики, предсмертного периода. Цена ошибки асимметрична: пропущенный «каприз» — тарелка; пропущенная дисфагия или депрессия — жизнь^{14, 24}. Отказ обрабатывается алгоритмом, не интуицией дежурного.

ОТКАЗ: КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЧИН

Причина	Признаки	Владелец решения
Организационная («невкусно», «не то», «холодное»)	Избирательно, на конкретные блюда	Кухня + администрация
Состояние (депрессия, тревога, психоз)	Изменение поведения, сна, контакта	Врач
Лекарственная (тошнота, седация, сухость)	Совпадение с назначением/сменой терапии	Врач
Дисфагия/соматика	Покашливание, долгий приём, боль, запор	Врач (срочно)
Осознанный отказ	Аргументированный, стабильный, при ясном состоянии	Житель (фиксируется)
Предсмертный период	Общее угасание, паллиативный статус	Врач + паллиативная служба

«Болит жевать» — частая маска: плохие протезы и сухость во рта — главные проблемы полости рта⁵¹. Вопрос «болит ли жевать» разделяет организационную и стоматологическую корзины; состояние полости рта — в пищевом паспорте (приложение 37).

ОТКАЗ: АЛГОРИТМ ЭСКАЛАЦИИ

Канадская норма: три отказа подряд и ≥ 25 % порции за два из трёх приёмов за неделю — триггеры врачебной оценки^{23, 56}. Проект российского правила (не российская норма):

1. Каждый отказ — журнал (приложение 9).
2. Отказ → альтернатива в тот же приём³⁴.
3. Три отказа подряд → врач в тот же день.
4. ≥ 25 % несъедено системно за неделю → врач + пересмотр карты.
5. Отказ от воды или от еды и воды → немедленно (литий и др.⁵³).
6. Эпизод завершается записью решения врача.

ОТКАЗ: НАСИЛИЕ НЕДОПУСТИМО — И ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ЮРИДИЧЕСКИ

Принудительное кормление недопустимо: противоречит ст. 5 ч. 2 Закона № 3185-1. Ст. 43 распространяет права ст. 37; ч. 2 ст. 37 — перечень прав пациента, не норма о гуманном

обращения⁸. Искусственное питание — решение врача. Для персонала: предлагать, заменять, адаптировать, фиксировать, эскалировать — не вводить силой.

ОТКАЗ: ДЕЕСПОСОБНОСТЬ И ОСОЗНАННЫЙ ОТКАЗ

Британская модель: дееспособность по конкретному решению в момент³⁸. Российская рамка — раздел 16. Осознанный отказ фиксируется в журнале и становится данными, не «нарушением».

ОТКАЗ: ПРЕДСМЕРТНЫЙ ПЕРИОД

В паллиативной фазе нутритивные цели уступают комфорту: режим Wunschkost^{28, 37}. Паллиативный маршрут питания — письменно (раздел 31).

ОТКАЗ: НАСИЛИЕ: ПОЧЕМУ ФОРМУЛИРОВКА ЖЁСТКАЯ

Схема «принуждение в исключительных случаях» расширяется усталостью смены. Физическое принуждение (удержание, шантаж, лишение «пока не съешь») недопустимо; истощение — врач (энтеральная поддержка, госпитализация). Позиция следует из ст. 5 ч. 2 закона 3185-1⁸.

ОТКАЗ: ПАЛЛИАТИВНОЕ ПИТАНИЕ: COMFORT FEEDING

В предсмертном периоде отказ — часть процесса. **Comfort feeding**: еда и питьё, пока приносят комфорт, без принуждения⁵⁷. Ретроспективное исследование без группы сравнения: медиана выживаемости 13 дней у паллиативных пациентов с деменцией⁵⁸ — не сравнение режимов. Обзор⁵⁷: прибавка веса при высококалорийных добавках; сильная роль предпочтений. Рамка comfort feeding меняет качество процесса, не доказанно — длительность.

ГИПЕРФАГИЯ: МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ЦЕНА АНТИПСИХОТИКОВ: ЧТО ДОКАЗАНО

Прибавка веса на антипсихотиках — измеренный классовый эффект. Мета-анализ 100 РКИ: от -0,23 кг до +3,01 кг за 6 недель¹³. Клинически значимая прибавка (≥ 7 % массы тела) при длительном применении (≈ 38 недель, Campforts et al., BJPsych Open, DOI bjo.2022.619): клозапин — 76,3 %, оланзапин — 36,9 %, рисперидон — 23,0 %⁹. При первом эпизоде психоза: +9,34 кг (оланзапин), +7,19 кг (клозапин)⁶⁰. Метаболический мониторинг предписан руководствами⁶¹.

ГИПЕРФАГИЯ: ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ: ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обзор RESOLVE: переедание — 4,4–45 %, тяга к еде — 16,1–64 %, ночное едение — 4–30 %⁴⁰. Эффект вмешательств скромный: мета-анализ образа жизни — $\approx -1,4$ кг⁶²; программа Teasdale эффективнее при диетологе⁶³. Стратегия — пищевая среда, мониторинг, врач.

ГИПЕРФАГИЯ: ЧТО МОЖЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ (БЕЗ ПОДМЕНЫ ВРАЧА)

Мониторинг веса: взвешивание на старте, 4-, 8-, 12-й неделе; триггеры +5 % за 3 месяца; онтарианские пороги 5/7,5/10 %^{61, 23}.

Пищевая среда: доступность между приёмами важнее запретов; буфет с фруктами вместо выпечки; лимит сладких напитков (раздел 11); структура приёмов без «дыр».

Добавка — по правилам: письменный порядок; медицинские ограничения порций — только врач поимённо (раздел 17).

ГИПЕРФАГИЯ: НОЧНОЕ ЕДЕНИЕ: СТРУКТУРИРОВАНИЕ

Ночные набеги — 4–30 %⁴⁰; корни: гиперфагия, нарушение сна, тревога. Замки на кухне неэффективны. **Структурированная ночная доступность:** поздний перекус, ночной доступ к воде, чаю, сухому перекусу на посту; сокращение интервала ужин–завтрак (11–14 ч^{30, 34}).

ГИПЕРФАГИЯ: РАЗГОВОР О ВЕСЕ: БЕЗ СТЫДА

Весогенность не лечится стыдом¹³. Формулировка: «побочный эффект лечения, который обходим вместе». Ограничения без объяснений обходятся через передачи и чужие тарелки.

ГИПЕРФАГИЯ: МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

График взвешивания (ежемесячно, одни весы, одно время); порог +5 % за квартал → врач. MUST (BAPEN) — скрининг истощения⁶⁴; набор и потеря — две строки панели (раздел 22). Пороги Онтарио ($\geq 5\%$ / 30 д, $\geq 7,5\%$ / 90 д, $\geq 10\%$ / 180 д)²³ — сигнал врачу сегодня.

ГИПЕРФАГИЯ: НОЧНАЯ ДОСТУПНОСТЬ: КОНСТРУКЦИЯ

Четыре элемента: **перечень** (2–3 продукта, согласованы с врачом); **место** (пост или буфет отделения); **режим** (окно 21:00–22:00, запись в журнал); **границы** (порционные объёмы при гиперфагии). На отделении 30 человек — от 1 до 9 с ночным едением⁴⁰.

ГИПЕРФАГИЯ: ЗАПОР: СКРЫТЫЙ РЕГУЛЯТОР АППЕТИТА

На клозапине запоры — 30–60 %, гипомотильность до 80 %; тяжёлый запор — илеус, перфорация, смерть; предупреждение TGA⁶⁵. NHS: мониторинг стула, слабительные по назначению⁶⁶. Учёт стула (да/нет); вода и клетчатка в меню; триггер — 3 суток без стула у жителя с антихолинергической нагрузкой → врач. Журнал стула — пост и врач; основание — соцслужбы / 152-ФЗ (раздел 17.6). *Слабительные — только врач.*

ГИПЕРФАГИЯ: МИКРОНУТРИЕНТЫ

Витамин D: дефицит в психиатрической популяции⁶⁷; карбамазепин снижает 25(OH)D⁶⁸. **B12 и фолат:** связь с депрессией и когнитивной⁶⁹. **Железо:** анемия маскируется под «не ест». Организация — пункт «обсудить с врачом» в годовом маршруте; анализы и добавки — врач⁶⁷.

ГИПЕРФАГИЯ: ИНСУЛИН И ВРЕМЯ ЕДЫ

Быстрое заглатывание. Риск удушья (choking) — документированная причина смерти⁴¹. Малые порции, исключение крупных сухих кусков, наблюдение, обучение приёму Геймлиха.

Опрокидывание, бросание. Безопасная посуда, finger food³⁵, отдельный стол, отложенная порция (раздел 12).

Поведенческие риски порождают «силовые» решения: связывание, изоляция от еды, кормление «наказанием». Каждое — вне закона (ст. 37 Закона № 3185-1: гуманное отношение и уважение достоинства)⁸ и вне доказательности: сила не изменяет гиперфагию, пикацизм, заглатывание. Изоляция при возбуждении — отдельная клиническая процедура (раздел 12.4, ³⁵), не инструмент дисциплины за столом. Локальный акт прямо запрещает лишение еды и питья как меру воздействия, «штрафные» порции. Строка положения о питании защищает жителя и директора.

11. Невербальный выбор

15.1. Масштаб вопроса

Три четверти жителей российских ПНИ признаны недееспособными⁷; значимая часть остальных не выражает выбор словом. Вариативность на вопросе «что будете?» исключает большинство. Технология невербального выбора — ядро системы, не дополнение.

15.2. Правовая рамка: поддержанное, а не подменяющее решение

Замечание общего порядка № 1 к ст. 12 КПИ: замещающее принятие решений подлежит замене поддержанным²⁶. Российское право: ст. 43 Закона № 3185-1 — статус⁸; ст. 29 ГК, 48-ФЗ — учёт мнения опекуном; 442-ФЗ — права получателя и ИППСУ. Выбор еды — бытовое решение, не сделка.

Маркировка: системное толкование; прямой нормы «выбор блюда не требует дееспособности» нет. Формы ниже — проект локальной практики.

15.3. Четыре канала воли

Канал 1. Показ вместо вопроса. Две реальные порции: указание, движение, взгляд, отворот⁷⁰.³⁵ Вариант Б должен существовать на линии (раздел 8).

Канал 2. Наблюдение за потреблением. Несъеданное — «нет», доеданное — «да». Журнал потребления (раздел 9)⁷¹.

Канал 3. Пищевая биография в «хороший день». Любимое, нелюбимое, ритуалы²⁸. Приложение 3.

Канал 4. Те, кто знает человека. Семья, опекун, работники — источники интерпретации с указанием источника²⁶.

15.4. Иерархия источников при расхождении

В локальном акте: (1) зафиксированная воля жителя; (2) текущая демонстрируемая воля; (3) сведения близких; (4) медицинские ограничения врача; (5) удобство кухни не входит. Ограничение определяет множество выбора³⁷.

15.5. Технология на линии

Сценарий^{2,3}:

1. Два варианта в одинаковых гастрорёмкостях.
2. Показ с простыми словами.
3. Реакция: указал / потянулся / отвернулся / без реакции.
4. Без реакции — вариант по карте, не «первый по очереди».
5. Потребление корректирует карту.

≈15–20 с на жителя; на отделение — несколько добавочных минут, компенсируемых снижением несъеденных порций. Утверждение «не могут выбирать» (раздел 37) проверяется: трёхдневный показ двух порций трём неговорящим жителям с записью реакции. При доле недееспособных 74 %⁷ технология невербального выбора составляет ядро вариативности, а не опцию для меньшинства.

15.10. Культурные и религиозные рамки

Халяль, кашрут, пост, вегетарианство — часть контингента; ст. 37 через ст. 43 закона № 3185-Р. Онтарио: культурные и религиозные предпочтения при поступлении²³. 442-ФЗ покрывает «индивидуальные потребности»⁷². Минимум: два вопроса в биографии; строка «ограничения по убеждению» в заказе. Пищевой паспорт — приложение 37.

15.11. Постные меню-циклы

Постное горячее 2–3 раза в неделю в периоды постов; постные гарниры ежедневно; маркировка в меню. **Пост — волеизъявление:** при диабете, БЭН, анемии — согласование с врачом; постный суп без белка не заменяет обед (приказ 520н)²⁹. **Отказ от поста — право жителя. Санитарный контур** для постных позиций тот же (раздел 18).

12. Дееспособность, опека и выбор еды

16.2. Нормативная основа

48-ФЗ: опекун учитывает мнение подопечного.

Закон № 3185-1: ст. 37 — права пациентов (гуманное отношение, достоинство); ст. 43 распространяет их на проживающих в СОСО, требует ежегодного освидетельствования⁸. Ст. 43 — статус, не норма об учёте мнения (ст. 29 ГК, 48-ФЗ).

442-ФЗ: права получателя (ст. 9), ИППСУ (ст. 16)⁷².

16.3. Карта решений: двенадцать вопросов

№	Вопрос	Ответ	Уровень
1	Отменяет ли недееспособность бытовые предпочтения?	Нет	Прямое следствие ст. 29 ГК; ст. 37/43 3185-1
2	Является ли выбор блюда «сделкой»?	Нет; бытовой акт	Системное толкование
3	Обязано ли учреждение учитывать мнение недееспособного?	Да	Норма (ст. 29 ГК; 48-ФЗ)
4	Может ли опекун «запретить» блюдо?	Только по медицинским назначениям	Системное толкование
5	Учреждение = опекун?	Конфликт интересов; прозрачные правила	Открытый вопрос + рекомендация
6	Нужно ли согласие на вариативное меню?	Нет: расширяет возможность выбора	Системное толкование
7	Отказ недееспособного от еды?	Наблюдение, альтернатива, эскалация (раздел 12)	Норма (ст. 37) + алгоритм
8	Может ли семья диктовать меню?	Источник сведений о воле	Толкование (GC1 ²⁶)
9	Кто решает об ограничениях рациона?	Только врач, поимённо	Толкование + ³⁷
10	Куда вписываются пищевые решения?	ИППСУ и локальные акты	Норма (442-ФЗ)
11	Проверяется ли учёт мнения?	Освидетельствование ст. 43; учредитель; прокуратура	Норма (3185-1)
12	Улучшилось состояние при недееспособности?	Суд решает; до решения — поддержанный выбор	Норма + практика

16.4. Конфликт интересов «учреждение = опекун»

1. Прозрачные правила (положение, триггеры, добавка).

2. Совет жителей и канал обращений (раздел 34).
3. Освидетельствование по ст. 43 — не формальность⁸.
4. Спорные случаи — учредителю письменно.

16.8. Учреждение = опекун: три антидота

До 74 % жителей ПНИ недееспособны, опекун — учреждение⁷ (вторичная аналитика). (1) Приоритет зафиксированных предпочтений над удобством — в положении (приложение 29). (2) Протоколирование разногласий с причиной. (3) Внешний элемент — совет жителей (раздел 34).

16.9. Как пользоваться картой

Карта применяется к конкретному решению в конкретный день. Три блока: **информирован** (показали в доступном формате); **понимает** (переспрос); **может сообщить** (раздел 15). Четыре категории: выбирает сам / с поддержкой / наблюдением / недоступен — стандартный вариант с пересмотром. Пересмотр при смене состояния; для «недоступен» — не реже квартала²⁶.

С 02.03.2015 — ограничение при психическом расстройстве с пониманием «лишь при помощи других»⁷³. Мелкие бытовые сделки — самостоятельно (п. 2 ст. 26); остальные — с согласия попечителя. Переход ст. 29 → п. 2 ст. 30 расширяет бытовую автономию, включая еду. Практика узкая⁷³. В карте дееспособности (приложение 37) фиксируется основание (ст. 29 или п. 2 ст. 30).

13. Право Российской Федерации: разрешено, требуется, недопустимо

17.1. Логика раздела

Правовая часть структурирована по трём зонам: разрешено или требуется прямо; допустимо при наличии процедур и документов; недопустимо независимо от намерений. Для каждого элемента указан уровень: норма, толкование, рекомендация.

17.2. Зелёная зона: прямые разрешения и требования

- 1. Питание ≥3 раз в день + диетическое по показаниям** — прямая санитарная норма для организаций соцобслуживания. На дату семинара (25–27.08.2026) действует СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7.1.11–7.1.14; с 01.09.2026 его сменяет СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (пост. Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 18), п. 56 подп. 11–14: питание проживающих в стационарных организациях соцобслуживания организуется не менее 3 раз в день, в том числе диетическое (лечебное) по медицинским показаниям⁹. Ни одна из редакций не ограничивает число вариантов блюд — только безопасность и периодичность.
- 2. Права получателя и учёт индивидуальных потребностей** — ст. 9 442-ФЗ (права получателя социальных услуг) и ИППСУ (ст. 16)⁷². Пищевые предпочтения и доступный выбор можно включать в ИППСУ; прямого субъективного права на ежедневный выбор блюда из нескольких вариантов закон не устанавливает.
- 3. Права проживающих:** гуманное отношение и достоинство — ст. 5 ч. 2 Закона № 3185-1; ст. 37 — перечень прав пациентов психиатрического стационара; ст. 43 распространяет ст. 37 на проживающих в стационарных СОСО⁸.
- 4. Рекомендуемые нормы питания Минтруда (приказ № 520н) и региональные нормы** на их основе — базовая рамка рационов^{29, 11, 12}. Ключевое слово: рекомендуемые — региональные нормы конкретизируют их для учреждений субъекта.
- 5. Таблицы замены продуктов** в раскладках — действующий механизм эквивалентной замены, легальная основа вариативности^{11, 12}.
- 6. Выбор блюд жителями** — не запрещён ни одной федеральной нормой; в 2024–2025 гг. реализован публично минимум в четырёх учреждениях трёх регионов^{2, 3, 4, 5, 6}.
- 7. Плата за стационарное соцобслуживание** ограничена 75 % среднедушевого дохода (ст. 32 ч. 4 442-ФЗ)^{72, 74} — рамка для финансовых моделей раздела 29.

17.3. Жёлтая зона: делать можно — через процедуру

Действие	Процедура	Основание
Ограничение рациона жителя (сахар, соль, порции)	Назначение врача поимённо, цель, срок пересмотра	Толкование + международная практика ³⁷

Действие	Процедура	Основание
Текстурные модификации (протёртое, загущённое)	Назначение врача, маркировка порций	Клиническая необходимость (раздел 10)
Изменение цикла меню	Увязка с региональной раскладкой и таблицами замен	11, 12
Пищевые карты жителей (персональные данные)	Основание обработки, ограничение доступа	152-ФЗ (раздел 17.6)
Отложенные приёмы, ночная доступность	Пункт в положении о питании + санитарный контур хранения	9
Совет жителей с полномочиями по меню	Локальный акт о совете	Практика + международные нормы ²³
Вариативное меню	Пакет документов (раздел 31) + уведомление учредителя	Рекомендация на практике ^{2, 3}

17.4. Красная зона: нарушения независимо от намерений

1. **Лишение еды или питья как мера воздействия** — прямое нарушение ст. 5 ч. 2 3185-1 (гуманное отношение); ст. 43 распространяет права ст. 37 на проживающих⁸.
2. **Насилие при кормлении** (принудительное бытовое кормление) — недопустимо; искусственное питание — только клиническая процедура по медицинским правилам (раздел 12.4).
3. **Имитация санитарного контроля** (суточные пробы «задним числом») — типовой состав дел по ст. 6.6 КоАП¹⁰.
4. **Недоброкачественные продукты на столе** — ст. 6.6 КоАП для должностного лица¹⁰.
5. **Картельные и согласованные закупки** — антимонопольная ответственность вплоть до уголовной (ст. 178 УК; практика ФАС)^{75, 76}.
6. **Отказ в питании «за опоздание»** как системная практика — нарушение доступности питания (п. 7.1.11 СанПиН 3590-20; с 01.09.2026 — п. 56 подп. 11 СанПиН 4282-26)⁹.

17.5. «Серая зона» лечебного питания: честная маркировка

Приказы Минздрава о лечебном питании (395н, 1008н, 330н и картотека диет) адресованы **медицинским организациям**; автоматического распространения на организации соцобслуживания они не имеют. Российская практика показывает обходную легализацию: региональные распоряжения применяют эти приказы к стационарным организациям соцобслуживания (пример — распоряжение Минсоцразвития Московской области 19РВ-32, на которое опирается ДДСОЛ с его советом по питанию)²². При наличии регионального «моста» лечебное питание оформляется по медицинской картотеке; при его отсутствии — диетические назначения через врача и положение о питании, без прямых ссылок на неадресные приказы. *Уровень: системное толкование + практика; до проверки в конкретном регионе не использовать как готовое решение.*

17.6. Пищевые карты и 152-ФЗ

Пищевая карта/биография жителя содержит персональные данные (сведения о здоровье — специальная категория). К той же категории относятся журнал стула (раздел 13.10) и список «время еды фиксировано» для инсулина (раздел 13.12). Правовой минимум: основание обработки (исполнение договора соцобслуживания/ИППСУ), ограничение круга доступа (пост и врач; кухня видит только функциональные ограничения, не диагноз), исключение избыточных данных, сроки хранения. *Уровень: рекомендация по применению 152-ФЗ; форма карты в приложении 3 требует локальной правовой проверки.*

17.7. КПИ: статус и практическое значение

Россия подписала Конвенцию о правах инвалидов в 2008 году и ратифицировала её в 2012 году; конвенция действует как международный договор РФ. Статья 28 (достойный уровень жизни, включая достаточное питание) и Замечание общего порядка № 1 к ст. 12 (поддержанное принятие решений) — международный стандарт, который российские суды и органы используют как ориентир толкования^{77, 26}. *Уровень: международный договор + толковательная практика; в локальных актах ссылаться можно как на обоснование, а не как на прямую обязанность формата «КПИ требует два варианта каши».*

17.9. КПИ и правовая культура: дальний горизонт

Конвенция о правах инвалидов с акцентом на поддерживаемое принятие решений²⁶ задаёт направление развития норм о выборе, предпочтениях и участии; австралийский Стандарт 6³⁹ и онтарийские требования²³ иллюстрируют этот вектор. Процедуры выбора, внедрённые добровольно, снижают затраты на последующее обязательное внедрение.

17.13. ПНИ и ДСО: различия в правовом статусе, которые важны для темы питания

Правовые режимы ПНИ и ДСО по теме питания **не совпадают**.

14. Санитария и пищевая безопасность при вариативности

18.1. Главный тезис: СанПиН — про безопасность, а не про однообразие

Санитарные правила для организаций социального обслуживания на дату семинара — СанПиН 2.3/2.4.3590-20: не менее трёх приёмов пищи в день, диетическое питание по показаниям, контроль на всех этапах — приёмка сырья, суточные пробы готовой продукции, бракераж, температурный режим, питьевой режим⁹. С 01.09.2026 3590-20 утрачивает силу; действует СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (пост. № 18 от 02.06.2026). Для стационарного соцобслуживания сохраняется тот же каркас: питание не менее 3 раз в день, в том числе диетическое (лечебное) по медицинским показаниям; суточные пробы — от каждой партии блюда (п. 56 подп. 11–14)⁹. Ни одна из редакций не ограничивает число вариантов блюда. Вариативность попадает в санитарный контур целиком: каждый вариант защищён теми же процедурами, что и мономеню, и каждый вариант должен их проходить. После 1 сентября локальные акты и чек-листы пищеблока перепривязываются к пунктам 4282-26, без изменения модели выбора.

18.2. Санитарный контур при двух вариантах

Маркировка. Варианты маркируются так, чтобы раздающий не мог перепутать: цветные маркеры, наклейки, порядок на линии. При текстурных модификациях маркировка — клинический, а не удобный элемент (раздел 10): перепутанная протёртая и обычная порция — риск аспирации.

Хранение остатков вариантов. Правила хранения и запрет повторного использования распространяются на оба варианта одинаково⁹; журнал замен фиксирует, что ушло в переработку по правилам, а что — в списание.

18.3. Типовые нарушения и цена

Прокурорская и надзорная практика по социальным учреждениям выделяет устойчивый набор: отсутствие или имитация суточных проб, недоброкачественные продукты, нарушение температурных режимов, отсутствие бракеража¹⁰. Ответственность по ст. 6.6 КоАП для должностного лица — штраф (в разобранных делах — 5 тыс. руб.)¹⁰; сумма мала, но само дело — проверка, представление прокуратуры и репутационный след. Кейс Кашина (СПЦ, 2022): прокуратура установила просроченные продукты и отсутствие проб — директор привлечён по 6.6¹⁰. *Маркировка: дела касаются учреждений соцобслуживания иных типов; для ПНИ это ограниченная аналогия с прямой переносимостью состава нарушений.*

18.4. Буфет, передачи и «серая еда»

Буфет/перекусы. Круглосуточная доступность перекусов — международная норма^{39, 30}; в российском контуре это значит: ассортиментный перечень буфета утверждён (без энергетиков,

с учётом раздела 11), продукты проходят тот же контур приёмки, сроки годности контролируются.

18.5. Ответственный за санитарный контур

При любой вариативности остаётся один ответственный: руководитель учреждения, делегирующий контроль через приказ (завхоз/шеф/диетсестра — по штату). Делегирование исполнения не отменяет ответственности за работающий контроль. Минимальный инструмент: еженедельный обход пищеблока руководителем или заместителем по чек-листу пищеблока (приложение 19) с записью.

18.8. Буфет и передачи: два хронических очага

Буфетная зона и комната передач — точки, где санитария сталкивается с правами жителей ежедневно. Буфет: допустимые категории (напитки, хлеб, упакованное, фрукты с мытьём), режим пополнения, ответственный — всё письменно. Передачи: перечень запрещённого (скоропорт, домашние заготовки открытые, алкоголь и энергетики — также по лекарственной таблице¹⁵), регистрация, хранение с маркировкой. Отсутствие регламента ведёт к полному запрету или бесконтролью.

15. Технология: пары блюд, раздача, журнал выбора

ПАРЫ: ИДЕЯ В ОДНОМ АБЗАЦЕ

Вариативность моделей М1–М2 (раздел 8) не требует второй линии производства. Она требует второго варианта **ключевого блюда**, приготовленного в том же потоке: каши А/Б варятся в двух котлах одновременно, вторые блюда А/Б — из одной мясной заготовки двумя способами. Это подтверждённая российская конфигурация: Болотнинский ПНИ (завтрак и обед, несколько раз в неделю)², Успенский ПНИ (два вторых, два салата, два напитка ежедневно)³, Иркутская модель (два первых, два вторых, гарниры)⁶.

ПАРЫ: ПАРЫ ЭКВИВАЛЕНТОВ

Вариант Б выбирается по трём фильтрам: эквивалентность по таблице замен (та же норма белка/круп)^{11, 12}; совместимость с потоком (та же печь, котёл, разделочная доска); предсказуемость спроса (статистика прошлых недель). Рабочие пары:

- **Крупы:** гречка / рис / пшено / овсянка — полностью взаимозаменяемы по таблицам замен.
- **Вторые:** котлета / тефтели; тушёное мясо / печёночный соус; рыба запечённая / рыбные биточки — одна заготовка, две формы.
- **Салаты:** свекольный / морковный; капустный / винегрет.
- **Напитки:** чай / какао / кофейный напиток (как в Болотнино²) — с учётом клозапинового правила: какао и кофейные напитки учитываются в кофейной строке пищевой карты (раздел 11).
- **Первые:** борщ / щи; суп крупяной / суп овощной — при готовности к двум котлам.

ПАРЫ: ТОЧКИ ВЫБОРА: С ЧЕГО НАЧИНАТЬ

Российская практика начинает с завтрака и обеда²: каши и вторые блюда имеют естественные пары, варятся в одном потоке. Порядок ввода: сначала одна позиция (каша или второе), потом вторая, потом салаты и напитки. Успенский ПНИ показывает конечную конфигурацию первого года: два вторых + два салата + два напитка ежедневно³.

ПАРЫ: ОБЪЁМЫ: ЖУРНАЛ ЗАКАЗА

1. **Заказ накануне:** вчерашний выбор жителей фиксируется (журнал заказа, приложение 7) и определяет сегодняшние объёмы варки.
2. **Стартовая пропорция:** пока статистики нет — 50/50 с резервом; через 2–3 месяца статистика стабилизируется^{3,4}.
3. **Пересчёт раз в две недели:** доля выбравших Б корректирует закупку; остатки вариантов фиксируются отдельно.
4. **Индикатор сбоя:** доля выбравших Б, не получивших Б, — стремится к нулю.

ПАРЫ: КТО ЭТО ДЕЛАЕТ: РОЛИ

Подтверждённая российская конфигурация: **диетсестра формирует перечень для выбора**². Распределение ролей: диетсестра (или завхоз) — пары эквивалентов и раскладка; повар — производство двух вариантов в одном потоке; раздающие/сиделки — предложение выбора и журнал; старшая смена — контроль «вариант Б существует» (приложение 24); руководитель — положение о питании и разбор ежемесячной статистики.

ПАРЫ: ЖУРНАЛ ЗАМЕН: НЕДООЦЕНЁННЫЙ ДОКУМЕНТ

Журнал замен — единственный документ, доказывающий, что отказ жителя обернулся альтернативой, а не голодом. Американская норма об обязательной альтернативе при отказе³⁴ описывает содержание этого журнала. Правила ведения: запись в день события; фиксируется не только «чем заменили», но и «принял ли»; серия замен одного блюда у разных жителей — сигнал кухне о блюде. Раз в месяц журнал замен читается вместе с журналом срывов.

ПАРЫ: ПАРЫ ЭКВИВАЛЕНТОВ: СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАБОР НА МЕСЯЦ

Эквивалентность проверяется по основному нутриенту позиции. Строительный набор: **каши** — гречка/рис/пшено/овсянка; **белковая позиция** — котлета мясная/рыбная/курица/биточек; **первые** — щи/борщ/суп крупяной; **салаты** — свёкла/капуста/морковь; **напитки** — компот/морс/чай. Два правила: пара должна быть реально различимой; оба элемента пары должны быть одинаково «ранговыми». Подтверждённая российская практика — две позиции второго, два салата, два напитка⁶.

РАЗДАЧА: ПОТОК: КАК НЕ СОЗДАТЬ ПРОБКУ

Предварительный заказ. Основной инструмент: выбор фиксируется накануне (журнал заказа), на линии — только выдача по списку с возможностью поменять решение. Российские внедрения работают именно так^{2,3}.

Визуальное меню. Фотографии или образцы двух вариантов до линии сокращают паузу «что там?» и помогают невербальному выбору (раздел 15).

Разнесение потоков. Самостоятельные жители — на линию; маломобильные получают выбор в жилой зоне по журналу заказа; кормимые — за столами, где еда приходит к ним.

Две точки выдачи. Позиции без выбора (хлеб, первое при едином супе) выдаются отдельно от позиций с выбором.

РАЗДАЧА: ПОДАЧА ПОМОЩИ: ЕДА — ПОД ГОТОВЫЕ РУКИ

Международный ориентир (не российское требование): один работник — не более двух полностью кормимых жителей; еда не подаётся, пока помощь недоступна²³. Тарелка, стоящая перед человеком, который не может есть сам и ждёт помощника, остывает; аспирация «на скорость» при спешке — клинический риск (раздел 10).

РАЗДАЧА: АТМОСФЕРА: РАЗДАЧА КАК СЕРВИС, А НЕ КАК РАЗДАЧА

Немецкий стандарт требует от персонала кухни выходить к жителям и проводить дегустации²⁸; финская норма — персонал за общим столом³²; австралийский стандарт формулирует ожидание жителя «я выбираю, что, когда, где и как я ем»³⁹. Минимальный пакет без затрат: раздающий

называет варианты вслух («гречка или рис?»); жителю дают 3–5 секунд на решение без давления очереди (предзаказ это обеспечивает); жалоба на блюдо принимается как данные и попадает в журнал.

РАЗДАЧА: АТМОСФЕРА: БЕСПЛАТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Международные программы среды (Pioneer, Eden, Green House^{78, 79, 36}) единодушны: обед читается жителями по атмосфере раньше, чем по меню. Элементы нулевой стоимости: скатерти и салфетки вместо «голового пластика»; еда на столах до рассадки; персонал не стоит полукругом «над» едящими; шумовой фон без бряцания тележек; освещение рабочее, а не казённо-верхнее.

РАЗДАЧА: ВЫБОР ВНЕ ЛИНИИ: ПОСТЕЛЬНЫЕ И ПОДНОС

Одиннадцать процентов жителей — постельные или маломобильные⁷. Если вариативность существует только на линии, она становится привилегией ходячих. Для этой группы выбор — **два варианта на подносе**: житель видит обе порции (или картинки на двери), стандартный вариант всегда есть, журнал заказа ведётся на посту. Температура доходит до комнаты по технологическим документам, замер — на последней выдаче, не только на линии (раздел 18.11 и приложение 45). Помощь приходит с едой, а не после неё (раздел 20.3).

ЖУРНАЛ: ТЕМА РАЗДЕЛА

Статистика выбора (управленческая). Доли выбора А/Б по позициям и неделям; блюда-лидеры остатков; доля «выбрал Б — не получил Б». Горизонт — месяц; владелец — диетсестра и руководитель. Опыт Усть-Илимска описывает «группировку блюд по популярности»⁴.

Правило пересчёта: каждые две недели доли выбора корректируют варку; каждый цикл меню статистика корректирует сам цикл (блюдо-аутсайдер по остаткам заменяется по таблице замен^{11, 12}). Международный ориентир для цикла: 21 день (Онтарио) и 4 недели (Германия) против типовых 14^{23, 31}; российский 14-дневный цикл — законный минимум, а не эталон.

К трём регистрам добавляется четвёртый канал — прямой разговор: ящик пожеланий, разбор меню на совете жителей (совет резидентов рассматривает каждый цикл меню^{23, 80}), дегустации новых блюд с голосованием (немецкая практика²⁸). Минимальная частота: раз в цикл меню. Каждое пожелание получает реакцию (принято / не принято с причиной) на следующем заседании; немецкий стандарт требует документированной системы жалоб со сроками ответа³¹.

16. Аудит и замеры

22.1. Принцип: измеряй факт, а не документ

Измерительный инструментарий: экспресс-аудит, семидневный замер и квартальная панель. Общее правило: измеряется факт (температура на последнем столе, остаток на тарелке, интервал в часах), а не запись о факте.

22.2. Экспресс-аудит «Стол за один день»

Чек-листы — приложения 18–21. Один случайный будний день, замеряющий — не профильный сотрудник. Четыре блока:

До еды: меню вывешено и написано языком блюд; совпадает с раскладкой; ночной интервал (вчерашний ужин → сегодняшний завтрак) в часах; журналы проб ведутся в реальном времени; лекарственно-пищевая таблица на посту.

Во время еды: число кормимых на одного работника; подача под готовую помощь; температура на первом и последнем столе; соответствие текстур назначенным (выборочно 3 тарелки группы риска); время на еду у самого медленного; объявлена ли добавка; ест ли персонал с жителями; остатки на тарелках; атмосфера.

После еды: журнал отказов ведётся и читается врачом; срабатывала ли эскалация «3 отказа → врач»; куда ушли остатки; существует ли вечерний перекус и доходит ли до постельных; что может съесть житель в 2 часа ночи (спросить дежурную сиделку).

Документы и люди: комплект из раздела 31; когда совет жителей в последний раз обсуждал меню; выходил ли повар к жителям за месяц; может ли кто-то за 5 минут назвать расход на сырьё на жителя в день.

Итог — 24 строки «да/нет/число», каждая становится строкой плана.

22.3. Семидневный замер отходов и потребления

Форма — приложение 25. Семь дней, три веса в день: выдано (кг по линии), возвращено с тарелок (кг), остатки кухни (кг). Результат — доля несъеденного по блюдам и дням, база для финансовой модели (раздел 29), корректировки цикла (раздел 21), разговора с учредителем (раздел 38). *Семь дней — короткий ряд; замер повторяется ежеквартально.*

22.4. Квартальная панель директора

Двенадцать чисел, собираемых раз в квартал (форма — приложение 35):

1. Ночной интервал (часы).
2. Доля несъеденных порций.
3. Блюда-аутсайдеры (топ-3).
4. Кормимых на одного работника (факт).
5. Температурная дельта «линия — последний стол».
6. Соответствие текстур назначенным (выборка).
7. Число отказов и доля с эскалацией в срок.
8. Весовые триггеры: (а) набор $\geq 5\%$ за квартал (раздел 13.8); (б) потеря по MUST / рамка Онтарио.
9. Доля жителей с актуальной пищевой картой.
10. Доля выбравших Б, не

получивших Б. 11. Сырьевая строка (руб./житель/день). 12. Число жалоб на питание и доля с ответом в срок.

22.5. Экспресс-оценка «за 10 минут»

Последовательность: экспресс-аудит (неделя 1 пилота), семидневный замер (недели 1–2), квартальная панель (постоянно).

17. Контекст: география системы и региональные нормы

ГЕОГРАФИЯ: АУДИТОРИЯ ПО ДОКУМЕНТАМ

Семинар «Пространство Новых Идей 2.0» собирает в Санкт-Петербурге руководителей стационарных организаций социального обслуживания со всей страны⁸¹. По списку участников: **170 записей из 51 субъекта Российской Федерации**; с учётом четырёх явных дублей — расчётно 166 уникальных организаций. Состав неоднороден: классические ПНИ (Краснодарский край, Ростовская, Нижегородская, Новосибирская области), переименованные «дома социального обслуживания» (Красноярский край, Волгоградская, Вологодская, Тюменская области), центры реабилитации и социализации (Воронежская область), «добрые дома» (Московская, Ульяновская области), геронтологические центры с отделениями ПНО (Владимирская область), а также детские и смешанные учреждения. Материал адресован руководителю стационарной организации, а не только ПНИ.

ГЕОГРАФИЯ: СИСТЕМА В ЧИСЛАХ (С ОГОВОРКАМИ О СТАТУСЕ ДАННЫХ)

По данным за 2024 год, обработанным аналитическим проектом «Если быть точным» (публикация 09.04.2026; материал также пересказывался СМИ, но ТАСС не является автором исследования) и перепроверенным по нескольким независимым изданиям^{7,82}:

- **466 психоневрологических интернатов** в России (три года назад — 536: сокращение на 13 %);
- **139 500 жителей ПНИ**; всего в стационарных организациях соцобслуживания — **более 174 000 человек** (данные Минтруда в пересказе);
- **65 % жителей старше 45 лет** — контингент стареет;
- **74 % признаны недееспособными** — три четверти;
- **11 % — постельные или маломобильные**;
- **средний размер — 289 коек**;
- **41 регион переименовал ПНИ** в «дома социального обслуживания» и подобные наименования;
- в сопровождаемом проживании — порядка **7 000 человек** из ПНИ (и 1 800 в программах распределённых квартир).

ГЕОГРАФИЯ: КТО УЖЕ ВНЕДРИЛ ВАРИАТИВНОСТЬ

В списке участников — организации с **подтверждёнными публичными практиками вариативного меню**: Успенский ПНИ³, Усть-Илимский дом социального обслуживания⁴, ДСО «Серафимовский»⁵, а также Болотнинский ПНИ из того же региона, что и Тогучинский².

РЕГИОН: ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА НОРМ ПИТАНИЯ

Российская рамка норм питания в стационарных организациях соцобслуживания двухуровневая. Федеральный уровень — **рекомендуемые нормы Минтруда** (приказ № 520н): суточные наборы продуктов для взрослых и детей²⁹. Региональный уровень — нормативные

акты субъектов, которые принимают эти нормы как обязательные для подведомственных учреждений, конкретизируют и дополняют: примеры — постановление Правительства Москвы № 1068-ПП, постановление администрации Псковской области № 206, постановление Правительства Красноярского края № 607-п, постановление Правительства Ленинградской области № 458, постановление Правительства ХМАО № 306-п^{83, 12, 11}.

РЕГИОН: ЧТО ОБЩЕГО У РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМ

Сопоставление проверенных актов показывает устойчивую конструкцию:

1. **Набор продуктов в граммах на человека в день** по группам — прямо или со ссылкой на федеральные рекомендации.
2. **Раскладка блюд** (перспективная картотека) — перечень блюд с выходом в граммах.
3. **Таблицы замены продуктов** — эквиваленты по питательной ценности: ключевой механизм, легализующий вариативность (разделы 8, 19).
4. **Отдельные нормы для категорий** (дети, лица с соматическими заболеваниями).
5. **Периодичность и режим** (число приёмов, интервалы) — в связке с СанПиН⁹.

РЕГИОН: РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ: ЧЕТЫРЕ АРХЕТИПА

Архетип 1. Классический ПНИ (Краснодарский край, Ростовская, Нижегородская, Новосибирская области): специализированное учреждение для лиц с психическими расстройствами. Именно этот архетип дал все три подтверждённые практики вариативности^{2, 3, 4}.

Архетип 2. Дом социального обслуживания (ДСО) (Красноярский край, Волгоградская, Вологодская, Тюменская области и др. — 41 регион переименований⁷): универсальное учреждение, где жители с психическими расстройствами живут вместе с другими категориями.

Архетип 3. Центры реабилитации и «добрые дома» (Воронежская, Московская, Ульяновская области): реабилитационная рамка; ближе к моделям М3–М5 лестницы (раздел 8).

Архетип 4. Смешанные учреждения с отделениями ПНО (Владимирская область и др.): психоневрологическое отделение внутри геронтологического центра — питание общего контура с отдельными назначениями.

РЕГИОН: ЧЕТЫРЕ АРХЕТИПА РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ: ДЕТАЛИЗАЦИЯ

Архетип «императивное меню»: утверждённое двухнедельное меню с граммовками, отступления не предусмотрены — вариативность начинается с изменения приложения.

Архетип «нормы без меню»: регион закрепил нутриенты и кратность, меню — дело организации. **Архетип «типовая раскладка»:** наследие советской раскладки, формально рекомендованной, фактически священной.

Архетип «мост»: акт, связывающий СОСО с системой диет (распоряжение 19РВ-32 как образец¹²). Один регион может комбинировать архетипы. Диагностика региона — заполненная форма из пяти строк: статус норм, меню, мост, формы учёта, закупочная модель.

18. Российские практики: подтверждённые кейсы и региональная модель

25.2. Кейс 1. Болотнинский ПНИ (Новосибирская область), с 2024 года

Что подтверждено сообщением учреждения от 16.08.2024²: вариативное питание действует **несколько раз в неделю**; на завтрак — выбор чая, какао или кофейного напитка, каши или супа; на обед — выбор салатов, вторых блюд и десерта; **перечень блюд для выбора определяет медсестра диетическая**.

25.3. Кейс 2. Успенский ПНИ (Новосибирская область), с 2024 года

Что подтверждено сообщением учреждения от 13.08.2024³: вариативное меню введено **во всех отделениях**; ежедневно предлагается **выбор из двух вторых блюд, двух салатов и двух напитков**; в учреждении отмечают, что «страхи персонала не подтвердились», жители «с лёгкостью освоили новую систему»; параллельно обновлена посуда и проведены занятия по правилам этикета.

25.4. Кейс 3. Усть-Илимский дом социального обслуживания (Иркутская область), с сентября 2024 года

Что подтверждено сообщением учреждения от 27.09.2024⁴: вариативное питание вводится **поэтапно**; старт — для жителей, посещающих столовую; предварительно проведён **опрос предпочтений**; блюда для выбора **сгруппированы по популярности**.

25.5. Кейс 4. ДСО «Серафимовский» (Санкт-Петербург), 2025 год

Что подтверждено сообщением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 22.07.2025⁵: директор дома Евгений Чистяков представил на заседании рабочей группы по реформированию ПНИ **первые результаты вариативного меню для части жителей**. Несколько месяцев проживающим предлагали **накануне выбрать рацион следующего дня из предложенного меню**. Для организации питания дом **закупил дополнительное оборудование и добавил сотрудников**. Жители восприняли эксперимент с энтузиазмом. Полный переход **крайне затруднителен**: соблюдение норм сбалансированности и учёт особенностей здоровья; жители склонны выбирать **популярные, но не самые полезные продукты**.

Развитие кейса: приказ № 124 от 10.03.2026⁸⁴. Приказ директора от 10.03.2026 № 124 утверждает **правила внутреннего распорядка жителей ДСО «Серафимовский»**, и в этих правилах закреплено **заказное питание (вариативное меню)** — в том числе для маломобильных граждан: «для маломобильных граждан приём пищи осуществляется в жилых комнатах, оказывается помощь в кормлении (при необходимости)». Вариативность переведена из эксперимента в **норму внутреннего распорядка**. *Маркировка: реквизиты — по PDF приказа, опубликованному на официальном сайте учреждения (www.pni9.ru; сайт прекратил работу —*

домен истёк, проверено 21.08.2026; текст правил сохранён в архивной копии: web.archive.org/web/20260415001233/https://www.pni9.ru/правила-внутреннего-распорядка/).

25.6. Региональная модель: Иркутская область, с 2025 года

По пресс-релизу (пересказ отраслевым изданием, 14.02.2025)⁶: в стационарных учреждениях области внедряется вариативное питание — **ежедневный выбор из двух первых блюд, двух вторых и гарниров**. Если конфигурация подтвердится первоисточником (сайт минсоцразвития Иркутской области), это первый в России случай **масштабирования вариативности на уровень региона**. *Маркировка: источник вторичный; масштаб (сколько учреждений фактически) на дату подготовки доклада не установлен.*

25.7. Опорная практика: ДДСОЛ (Московская область)

Дом-интернат для лиц с ментальными нарушениями ДДСОЛ публикует устройство питания²²: зимнее и летнее **14-дневное меню**, 5–6-разовое питание, поточная линия самообслуживания, буфетная зона, **совет по питанию** (на основе распоряжения Минсоцразвития Московской области 19РВ-32 от 13.04.2017), **замены по желанию жителей с согласованием с врачом**. Это не «вариативное меню» в строгом смысле, но модель персонализации и участия жителей внутри действующей нормативной рамки — и пример легального «мостика» к лечебному питанию (раздел 17.5).

25.8. Сравнительная таблица практик

Учреждение	Модель	Точки выбора	Частота	Охват	Ответственный	Особенности
Болотнинский ПНИ	M1	Завтрак, обед	Неск. раз/нед	Данных нет	Диетсестра	Перечень от медицинской структуры
Успенский ПНИ	M2	Все основные позиции	Ежедневно	Все отделения	Данных нет	Посуда, этикет, работа со страхами
Усть-Илимский ДСО	M1→M2	Старт — столовая	Поэтапно	Мобильные жители	Данных нет	Опрос предпочтений, группировка по популярности
Серафимовский ДСО	M1	Рацион на следующий день	Накануне, неск. месяцев	Часть жителей	Данных нет	Оборудование и доп. сотрудники; полный переход затруднителен
Иркутская область	M2	2 первых, 2 вторых, гарниры	Ежедневно	Регион	Учредитель	Масштабирование на субъект
ДДСОЛ	персонализация	Замены по желанию	Постоянно	Все жители	Совет по питанию + врач	14-дневное меню, региональный «мостик» к 330н

25.9. Выводы

1. **Вариативность в России — не эксперимент:** минимум четыре учреждения и один регион — публично, с 2024 года^{2, 3, 4, 5, 6}.
2. **Три кейса Новосибирской и Иркутской областей начинались без новых денег** — второй вариант внутри существующих норм и потоков. **Серафимовский публично назвал оборудование и дополнительные ставки⁵.**
3. **Документация практики отстаёт от практики:** деталей (учёт, статистика, документы) в публичных сообщениях нет (раздел 39).

19. Международные ориентиры и границы переноса

Предыдущий раздел блока «Контекст» — 25 «Российские практики»: Болотнинский, Успенский, Усть-Илимский, Серафимовский, ДДСОЛ и региональная модель Иркутской области. Здесь — то, что в этих четырёх российских кейсах не видно: ориентиры и предупреждения из девяти зарубежных систем.

26.2. Великобритания: психиатрическая специфика

Единственное выявленное нами руководство, написанное **именно для психиатрических стационаров**, — Британской диетической ассоциации (BDA)^{35, 85}. Заимствуемые инструменты: гибкий завтрак для седатированных; меню без приборов (finger food) для состояний с риском; протокол питания в изоляции (посуда, текстура, фиксация потребления, эскалация); лекарственно-пищевая таблица в меню (наш раздел 11); self-catering на реабилитационных отделениях. Базовый стандарт — Regulation 14 регулятора CQC: учёт предпочтений **по времени, месту и количеству еды**, а не только по составу; отложенная еда для пропустивших³⁸. Практика «защищённых приёмов пищи» приводится с честной оговоркой: систематический обзор признаёт её доказательную базу недостаточной^{86, 87}.

26.3. Австралия: еда как самостоятельный стандарт

С 1 ноября 2025 года действует Standard 6 «Food and Nutrition» — питание как отдельный стандарт качества ухода: формула выбора **«что, когда, где и как я ем»**, перекусы 24/7, меню с участием проживающих, текстуры по IDDSI с достойной подачей и процедурой «осознанного риска»^{39, 44}. Финансовая подпорка — следствие скандала: медиана расходов на сырьё \$8,00 AUD в день (исследование Hugo)⁸⁸ → надбавка \$10 AUD **в обмен на обязательную ежеквартальную отчётность о расходах на питание**⁸⁹. Механизм «деньги в обмен на прозрачность» — самый переносимый финансовый элемент международного опыта (раздел 29).

26.4. Онтарио: решётка измеримых норм

Подзаконный акт О. Reg. 246/22 — самая детальная из найденных нормативных конструкций²³: цикл меню ≥21 день; выбор на всех приёмах пищи; **совет резидентов рассматривает каждый цикл меню и согласует время приёмов**; еда по диете доступна 24 часа; триггеры веса −5 %/−7,5 %/−10 % за 1/3/6 месяцев с автоматической междисциплинарной оценкой; диетолог ≥30 минут на жителя в месяц; **кормление: один работник — не более двух кормимых, еда — только под готовую помощь**. Профессиональные формы добавляют триггеры потребления: ≥25 % порции за 2 из 3 приёмов в течение недели; отказ от трёх приёмов подряд⁵⁶. Почти вся эта решётка переносима в российский локальный акт без изменения закона — что и сделано в разделах 12, 20, 21.

26.5. США: альтернатива при отказе и ночной интервал

Федеральное правило 42 CFR §483.60³⁴: при отказе от блюда **обязательна альтернатива сходной питательной ценности**; между существенным ужином и завтраком — **не более 14 часов** (16 — при питательном перекусе на ночь). Нарушения фиксируются пронумерованными инспекционными F-тегами (F800–F807 — пищевой блок)⁹⁰: механика пронумерованных проверяемых пунктов переносима во внутренний аудит учреждения (приложения 18–24).

20. Доказательные вмешательства и их границы

27.1. Зачем раздел и как его читать

Доклад опирается на исследования, но не превращает их в рекламу методик. Правило раздела: каждое вмешательство приводится с популяцией, дизайном и ограничениями; вывод «работает» делается только там, где это позволяют данные. Главный методический факт, который нужно держать в уме: **почти вся доказательная база организационных вмешательств в питании получена в гериатрии и деменс-уходе, а не в психиатрии** — перенос на ПНИ требует адаптации и собственного измерения (раздел 22).

27.2. Вмешательства с измеримым эффектом

Семейная подача (family-style dining). Nijs и соавт., 2006: кластерное РКИ в **пяти голландских домах ухода, 178 жителей без деменции** (не психиатрический контингент ПНИ/ДСО). Общие блюда на столе дали рост качества жизни (+6,1 балла), массы тела (+1,5 кг) и потребления энергии (+991 кДж/день) против контроля³³. Перенос на российские ДСО и на отделения с деменцией **не обоснован**; механизм (социальность + саморегуляция порций) можно обсуждать точно, не как норму. Для острых состояний — нет.

IDDSI и текстуры. Интервенционное исследование в пяти учреждениях: адресная программа подняла соответствие поданных текстур назначенным с 44 % до 90 % (жидкости: 31 % → 100 %), эффект держался 6 месяцев; барьер — осведомлённость персонала⁴³. Перенос прямой: популяция с дисфагией есть в любом ПНИ (раздел 10).

Монтессори-подход к еде. Программы обучения персонала деменс-ухода (Montessori-based activities) улучшают самостоятельность еды и снижают проблемное поведение за столом⁷⁰. Перенос: применим для отделений с когнитивными нарушениями; это подход к обучению навыку, а не к меню.

Доплаты за нутритивный менеджмент (Япония). Крупные административные массивы: доплата ассоциирована с меньшим риском ухудшения ухода (HR 0,90); диетологи — с меньшим риском потенциально предотвратимых госпитализаций (скорректированный HR 0,72; 95 % ДИ 0,54–0,97)^{91, 92}. *Ограничение: наблюдательные данные, возможен отбор; причинность не доказана.*

27.3. Вмешательства со слабой или отрицательной доказательностью

Защищённые приёмы пищи (protected mealtimes). Популярная британская практика; систематический обзор: доказательная база **недостаточна** — исследования малочисленны и неоднородны^{86, 87}. Вердикт доклада: разумно и бесплатно, но не «доказано»; внедряется как организационная гигиена без обещания эффекта.

Образ жизни для снижения веса при ТПР. Мета-анализ: средний эффект порядка –1,4 кг⁶² — статистически реальный, клинически скромный. Программы с диетологом сильнее⁶³.

Вердикт: метаболическая стратегия строится на среде и мониторинге (раздел 13), а не на ожидании больших цифр.

Малые дома (Green House, Eden Alternative). Оценки показывают улучшение показателей качества жизни и питания в моделях малого дома^{36, 79}; это системные реформы (штат, архитектура, финансирование), а не «приёмы» — переносятся как горизонт, а не как действие на следующей неделе.

27.4. Что доказано про вес и препараты (свод клинического ядра)

Для удобства директора клинические факты доклада собраны в одну таблицу; все они разобраны в разделах 11–13 со ссылками:

21. Персонал стола и совет жителей

ПЕРСОНАЛ: ПОЧЕМУ ТЕМА ПЕРСОНАЛА — ПОЛОВИНА ТЕМЫ СЕМИНАРА

Формула темы семинара — «права, свободы, интересы жителей и персонала» — не случайна. Каждое изменение в питании исполняют руки: сиделка предлагает выбор, повар варит второй вариант, раздающий держит темп, диетсестра ведёт раскладку, завхоз отвечает за пробы. Доклад, игнорирующий их нагрузку, интересы и страхи, не будет исполнен — об этом прямо говорит опыт Успенского ПНИ, где главным препятствием оказались не деньги и не нормы, а «страхи персонала»³. Раздел разбирает людей за линией: роли, нагрузку, обучение, мотивацию и ошибки управления.

ПЕРСОНАЛ: РОЛИ И ИХ РЕАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

Сиделка/санитар. Ключевая фигура стола: кормит, наблюдает, фиксирует, предлагает выбор. Добавочная нагрузка вариативности — 5–10 секунд на жителя на линии и несколько строк в журналах; добавочная нагрузка клинического контура — замечать признаки (дисфагия, отказы) и знать одну фразу эскалации. Это реальные минуты, и честный план закладывает их в смену, а не в «энтузиазм».

Повар. При парных эквивалентах второй вариант — та же заготовка в другой форме (раздел 19): нагрузка растёт на гастроремкости и маркировку, а не на «второе производство». Зато впервые появляется обратная связь: повар видит, что его блюдо выбирают. Немецкая практика делает это инструментом мотивации — повар выходит к жителям с дегустациями²⁸; российская адаптация: дегустация новых блюд цикла с голосованием совета жителей.

Диетсестра (или завхоз при её отсутствии). Владелец раскладки, таблиц замен и пар эквивалентов; подтверждённая российская конфигурация — именно диетсестра формирует перечень для выбора². Это единственная роль, где вариативность добавляет интеллектуальную, а не механическую работу: подбор пар, пересчёт объёмов по статистике (раздел 21).

ПЕРСОНАЛ: НОРМА ПОМОЩИ: САМАЯ БОЛЕЗНЕННАЯ ЦИФРА

Ориентир 1:2 (один работник — не более двух полностью кормимых)²³ для большинства российских учреждений недостижим текущими штатами — и доклад не делает вид, что это решается приказом. Честная конструкция из трёх шагов:

ПЕРСОНАЛ: ОБУЧЕНИЕ: ТРИ УРОВНЯ ЗА ТРИ ИНСТРУКТАЖА

Программа обучения стола не требует учебного центра — требует трёх сорокаминутных инструктажей с проверкой усвоения «на линии»:

Международные данные подтверждают: главный барьер качества — осведомлённость персонала (в исследовании IDDSI — от 5 до 79 % в разных домах)⁴³. Обучение — самая дешёвая точка рычага во всём докладе.

ПЕРСОНАЛ: МОТИВАЦИЯ И ВЫГОРАНИЕ

Питание — эмоционально тяжёлая зона работы: кормление, отказы, конфликты, запахи, темп. Три рабочих механизма удержания людей, проверенные логикой практик:

Видимый смысл. Персонал, видящий разницу в остатках и в лицах жителей после внедрения выбора, становится союзником программы — поэтому статистика пилота (раздел 35) доводится до смены, а не только до учредителя.

ПЕРСОНАЛ: ТИПОВЫЕ ОШИБКИ УПРАВЛЕНИЯ

1. **«Приказал — значит внедрил»:** без инструктажа и проверки усвоения приказ производит имитацию.
2. **Нагрузка «в подарок»:** новые процедуры без пересмотра смены — перегруз и откат.
3. **Наказание за данные:** сиделка, оштрафованная за честную запись об отказах, перестанет записывать — и система ослепнет.
4. **Изменение без объяснения «зачем»:** персонал, не понимающий смысла выбора, видит в нём только лишнюю работу — и оказывается прав по-своему.

ПЕРСОНАЛ: ЧТО СКАЗАТЬ СТАРШЕЙ СМЕНЕ В ПОНЕДЕЛЬНИК

Письменные роли, включая врача. Замер нормы помощи. Три инструктажа с проверкой на линии. Статистика пилота — до смены, не только до учредителя. В Успенском «страхи персонала не подтвердились»³ после того, как их озвучили.

СОВЕТ: ПРАВОВАЯ РАМКА

Права жителей СОСО: ст. 37 закона 3185-1 (уважение достоинства, гуманное обращение) через ст. 43⁸. Конвенция о правах инвалидов — ст. 28; Замечание общего порядка № 1: учёт воли и предпочтений^{77, 26}. Прямой конструкции «права на выбор блюда» в российском законе нет (раздел 17); выбор реализует существующие права.

СОВЕТ: ТРИ МОДЕЛИ УЧАСТИЯ

Информационная: извещение о меню (доска, визуальное меню). Минимальный уровень без влияния на решения.

Консультативная: опросы, дегустации, сбор пожеланий (опыт Усть-Илимска⁴). Влияние при административном ритме.

Институциональная: совет жителей (образец ДДСОЛ, распорядительный документ от 13.04.2017)²². Обсуждение меню до утверждения, дегустации, ранжирование пожеланий, отчёт об исполнении. Устойчивость при смене руководства отделений.

СОВЕТ: СОВЕТ ЖИТЕЛЕЙ: ОРГАНИЗАЦИЯ

Состав: 5–9 человек — жители (включая недееспособных через представителей), сиделка, повар, врач (совещательный голос). Квоты по отделениям.

Полномочия: обсуждение меню; дегустации; сбор пожеланий; получение ответа в срок. Полномочия не должны превышать исполнимое администрацией.

Ритм: ежемесячное заседание, протокол (приложение 30). Протокол — доказательная база для раздела 32.

СОВЕТ: НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ ЖИТЕЛИ

74% жителей ПНИ — недееспособные⁷ (раздел 23). Форматы: представительство; наблюдательные методы (раздел 15) с занесением в пищевую карту; ротация пробных обедов. Международные нормы: Австралия, Стандарт 6 с 01.11.2025³⁹; Онтарио — учёт preferences²³.

22. Финансы и закупки

ФИНАНСЫ: ЧЕСТНАЯ РАМКА: ЧТО МЫ НЕ УТВЕРЖДАЕМ

В прежних версиях этого материала встречалась формула «вариативность почти бесплатна». Она удалена. Честная позиция: стоимость вариативности зависит от модели и измеряется замером; утверждать экономию без данных нельзя, утверждать невозможность без данных тоже нельзя. Раздел даёт инструментарий счёта: три стоимости питания, пять моделей вариативности с их ценой и порядок замера. Все числовые примеры помечены как иллюстративные.

ФИНАНСЫ: ТРИ СТОИМОСТИ, КОТОРЫЕ ПУТАЮТ

Сырьевая строка — продукты на жителя в день. Международные ориентиры (с годом и валютой, не нормативы для РФ): медиана \$8,00 AUD (Австралия, исследование Hugo)⁸⁸; Онтарио: «скандальные» \$8,33 CAD, выросшие до \$13,71 CAD после публичной кампании^{93, 94}; США: более четверти домов в 2025 году опустили ниже \$10 (данные отраслевой ассоциации ANFP — не госоргана)^{95, 96}. Урок для нас не в цифрах, а в механизме: во всех трёх странах изменения начались с публикации сырьевой строки^{89, 94}.

Полная стоимость приёма пищи — сырьё + труд кухни + энергия + амортизация. Канадский аудит оценивал её в \$27,91–54,85 за жителя в день — в 3–6 раз выше сырьевой строки⁵⁶. Вывод: экономия на сырьё при огромной полной стоимости — самая неэффективная экономия системы.

Стоимость кормления — время помощников за столом. Оценка тех же канадских данных — до 45 минут в день на жителя группы помощи⁵⁶. Это самая дорогая и самая скрытая строка: она живёт в штатном расписании, а не в продуктовом бюджете.

ФИНАНСЫ: СЫРЬЕВАЯ СТРОКА: КАК ПОСЧИТАТЬ СВОЮ ЗА ЧАС

Формула (методика — приложение 25): расходы на продукты за месяц ÷ число жителей ÷ число дней = руб./житель/день. Три правила интерпретации: считать только продукты (без труда и коммуналки); сравнивать с собой в динамике и с региональными коллегами, а не с зарубежными долларами (структуры цен разные); публиковать — учредителю и совету жителей, потому что прозрачность строки во всех изученных странах работала на её рост^{89, 93}. Если никто в доме не может назвать эту цифру за пять минут — это первая находка аудита (раздел 22).

ФИНАНСЫ: ПЯТЬ МОДЕЛЕЙ ВАРИАТИВНОСТИ И ИХ ЧЕСТНАЯ ЦЕНА

Модель	Что меняется	Цена сырья	Цена труда	Разовые затраты
М1. Выбор из двух (завтрак+обед, 2–3 дня/нед)	Вторая гастроёмкость, журнал заказа	~0 (перераспределение пар)	+минуты на линии	Гастроёмкости, маркеры
М2. Выбор ежедневно по позициям	Тот же принцип в полном объёме	~0 при пересчёте по статистике	+время раздачи и учёта	Визуальное меню
М3. Буфетная зона (салаты/напитки)	Самообслуживание в зоне	Рост потребления → пересчёт	Контроль зоны	Стеллажи, посуда

Модель	Что меняется	Цена сырья	Цена труда	Разовые затраты
М4. Семейная подача (точечно)	Подача общими блюдами	~0	Меняется роль персонала	Столовая посуда
М5. «Своя кухня» (реабилитация)	Программа навыков	Как у группы	Персонал-сопровождающий	Кухонная зона

Модельные оценки, не замеры: фактическая цена определяется семидневным замером до старта и через 90 дней (приложение 25).

ФИНАНСЫ: ОТХОДЫ: ЕДИНСТВЕННАЯ ЧЕСТНАЯ «ЭКОНОМИЯ»

Логика экономии вариативности проста: несъеденная порция — это оплаченное сырьё в мусорном ведре; выбор снижает долю несъеденного, потому что нелюбимые блюда перестают попадать на тарелку. Но: (1) доказательной базы эффекта в наших условиях нет (раздел 27.5); (2) поэтому формула доклада — **замер до и после**. Семидневный замер отходов до пилота и через 90 дней даёт собственную цифру, которая и есть честный ответ на вопрос «сколько экономит выбор» — у вас, а не в среднем. Международные аналоги (снижение остатков при улучшении качества и выбора) существуют⁹⁷, но переносятся только как гипотеза.

ЗАКУПКИ: АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ЗОНА: ПРАКТИКА ФАС

Проверенная практика показывает масштаб рисков: ФАС раскрыла картель на торгах по поставке социально значимых продуктов — 543 торга на 4,7 млрд рублей (Москва, Московская область, Владимирская область, Дагестан; 2024)⁷⁵; в Челябинске — картель на 27 тендерах школьного питания со штрафом и уголовным делом по ст. 178 УК (2025)⁷⁶. Для директора учреждения-заказчика выводы три:

Маркировка: практика ФАС приведена по публичным сообщениям; для конкретных закупочных решений требуется заключение контрактной службы/юриста.

ЗАКУПКИ: ЗАКУПКА И ВАРИАТИВНОСТЬ: СТЫКОВКА

Порядок действий, увязывающий вариативность с закупочным циклом:

1. Статистика выбора за 2–3 месяца (раздел 21) → пропорции пар в спецификации.
2. Сезонность и праздничное меню → корректировка квартальных объёмов (совет жителей, раздел 34).
3. Таблицы замен → «запасные эквиваленты» в спецификации на случай срыва поставки.
4. Малые партии скоропорта → график поставок, а не склад.
5. Раз в год — пересмотр спецификации по замеру отходов (приложение 25): что стабильно не съедается, уходит из закупки законно, через таблицы замен^{11,12}.

23. Документы, проверка и ответственность руководителя

ДОКУМЕНТЫ: НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА

Документальный комплект закрепляет границы практики, распределяет ответственность по должностям и обеспечивает воспроизводимость при смене персонала. Материалы разделов 17–30; шаблоны приложений 1–36 — **проекты локальных форм**, требующие адаптации под региональные нормы и согласования.

ДОКУМЕНТЫ: ШЕСТЬ БАЗОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Положение об организации питания (локальный акт): нормативная база (3185-1 ст. 43, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и с 01.09.2026 — СанПиН 2.3/2.4.4282-26, приказ Минтруда 520н — с указанием рекомендованного характера норм при отсутствии регионального императива)^{8, 9, 29}; структура питания; роли; учёт индивидуальных потребностей. Утверждается директором, согласовывается с учредителем.

3. Меню с вариантами. Цикл 14–28 дней (ориентир международных норм^{23, 31}; в РФ императива цикла для СОСО нет). Каждая вариативная позиция — пара эквивалентов с нутриентным обоснованием (раздел 19).

4. Журналы заказа и замен. Журнал замен документирует исполнение нормы об альтернативе при отказе (США — прямо³⁴; РФ — вывод из ст. 37 3185-1 в связке со ст. 43⁸, раздел 17).

5. Пищевые карты жителей: предпочтения, запреты, текстура (IDDSI при показаниях)⁴², помощь, лекарственные ограничения (раздел 11). Формат — приложение 7; иерархия источников — раздел 15.

6. Согласование с учредителем: письмо-отчёт о пилоте с панелью 12 чисел (раздел 22). Изменения, проведённые через учредителя, устойчивее при проверках^{3, 4}.

ДОКУМЕНТЫ: КЛИНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

7. Лекарственно-пищевая таблица (раздел 11, приложение 21): пять правил взаимодействий. Подпись врача; размещение на кухне и в постовой.

8. Список дисфагического риска (раздел 10, приложение 21): признаки, уровень текстуры, приём «два обученных человека на посту»¹.

ДОКУМЕНТЫ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

10. Приказ об ответственных (питание, вариативная линия, журналы, связь с врачом).

11. Регламент совета жителей (раздел 34, приложение 30).

ДОКУМЕНТЫ: УЧЁТНАЯ ФОРМА

Для учёта продуктов в СОСО — формы по приказу Минфина 52н; переход на электронные формы — поэтапно (приказы 61н, 142н, 100н, 157н, 174н)⁹⁸. Статус конкретной формы

подтверждается учредителем или региональным органом. Журнал заказа ведётся параллельно учётной форме.

ДОКУМЕНТЫ: ПОРЯДОК СБОРКИ (ПЯТЬ РАБОЧИХ ДНЕЙ)

День 1: приказы об ответственных и о пилоте (приложения 17, 28). День 2: положение с разделом о вариативности (приложение 29). День 3: клинический блок — таблица, список риска, журнал отказов (приложения 21, 9); подпись врача обязательна. День 4: журналы, меню с парами, пищевые карты (приоритет — группа риска). День 5: регламент совета (приложение 30), панель (приложение 35), письмо учредителю. Критерии готовности: ориентация нового сотрудника за час; ответы на вопросы проверяющего (раздел 32).

ДОКУМЕНТЫ: ПРИНЦИП СОКРАЩЕНИЯ

Избыточность определяется незаполняемостью в ритме смены. Каждая графа журнала должна соответствовать управленческому решению; графы без решения исключаются.

ПРОВЕРКА: НАЗНАЧЕНИЕ РАЗДЕЛА

Раздел систематизирует надзорные контуры и соотносит типовые вопросы с документами комплекта (раздел 31). Основа — материалы административных дел^{75, 76} и надзорные документы¹⁰; не является юридической консультацией по конкретному делу.

ПРОВЕРКА: НАДЗОРНЫЕ КОНТУРЫ

Роспотребнадзор — санитария: СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7.1.11–7.1.14; с 01.09.2026 — СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 56 подп. 11–14 (питание не менее 3 раз в день, в том числе диетическое по показаниям; суточные пробы)⁹. Вопросы касаются температуры, маркировки, проб, поточности; вариативность — дополнительная линия (раздел 18).

Прокуратура — по жалобам о правах жителей. Опорные нормы — ст. 37 и 43 закона 3185-¹⁸. Журнал отказов и документированный выбор — элемент доказательной базы.

«Где гарантия, что житель получил норму?» Журналы заказа и замен: выбранное, стандартное или зафиксированная замена. В США — федеральная норма об альтернативе³⁴; в РФ — толкование ст. 37/43⁹ с документированием.

«Кто разрешил?» Приказ директора и отчёт учредителю^{6, 22}.

ПРОВЕРКА: ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫПИСАННОМ ЗАМЕЧАНИИ

Фиксация формулировки; запрос нормы-основания⁷⁵; подключение учредителя на стадии возражения; оценка обжалования с юристом. Статистика отменённых замечаний по вариативному питанию отсутствует.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПРИНЦИП РАЗДЕЛА

Раздел представляет обзор применявшихся составов по «пищевым» сюжетам в организациях соцобслуживания и влияние вариативности на риск-профиль. Не является юридическим заключением.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: КОАП СТ. 6.6

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Публичные дела: СРЦ «Кашинский» (2022)¹⁰; Зеленогорский ДИПИ (2021, ТАСС)¹⁰ — о качестве и достаточности, не о вариативности. Дел о «двух вариантах» в публичном поле не обнаружено.

Постановление ВС РФ от 21.02.2019 № 11-АД19-4: дом-интернат не является организацией общественного питания — питание в рамках социальной услуги²¹. Квалификация не отменяет санитарных требований; документальный след (меню, акты, журналы) остаётся основной защитой.

Вектор	Частота (публичная практика)	Тяжесть	Повышает	Снижает
Жалоба жителя/родственника	высокая	низкая	раздача без записи	журнал выбора и замен, совет жителей (разд. 34)
Прокурорское представление	средняя	низкая – средняя	неразобранная жалоба	регламентный разбор (прил. 34)
Административное дело 6.6 КоАП	низкая, реальная	средняя	недоброкачественные продукты, имитация проб	пробы, бракераж, температурный контур, меню и акты
Уголовные составы (238/285/286/293)	не выявлено	высокая, крайне редкая	системное бездействие при известном вреде	контроль и своевременная реакция

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ ВАРИАТИВНОСТИ

Снижение риска: документированный выбор снимает повод «невкусно, не ем»; журнал замен закрывает сюжет «оставили голодным»; совет жителей (раздел 34). Международные нормы о выборе^{34, 23, 39}.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ЭЛЕМЕНТЫ СНИЖЕНИЯ ЛИЧНОГО РИСКА

Коллегиальность следов; клиническая делегация (подпись врача); скорость реакции на жалобу; корректная маркировка статуса документов как проектов^{75, 76}.

24. Пилот на 90 дней и дорожная карта на 12 месяцев

ПИЛОТ: ОБОСНОВАНИЕ СРОКА И ФОРМАТА

Пилот ограничивает изменения одной точкой (отделение или приём пищи), сохраняя предсказуемость среды (раздел 9). 90 дней — срок проявления статистики выбора (первые две недели — эффект новизны), трудовых издержек и конфликтов. Опыт Усть-Илимска — поэтапное расширение⁴; Успенского — фиксация после пробного периода³.

ПИЛОТ: ДНИ 1–14: ПОДГОТОВКА

Неделя 1. Приказ о пилоте (приложение 28): точка, сроки, ответственные, критерии успеха и остановки. Замер «до» — семь дней: отходы, время раздачи, отказы (приложение 25).

Неделя 2. Опрос предпочтений (приложение 36) → пищевые карты. Инструктаж смены (раздел 28); уведомление учредителя.

ПИЛОТ: ДНИ 15–75: ИСПОЛНЕНИЕ

Формат: модель М1 (раздел 29) — два варианта второго на обед, 2–3 дня в неделю, заказ накануне или на линии. Гарантия стандартного варианта. Журналы — с первого дня.

Еженедельная планёрка: выбор, очередь, замены, обратная связь. Проблемы: смена / кухня / администрация; третья категория — не более двух недель без решения.

Ночная доступность (раздел 13): структурированный перекус по согласованию с врачом.

ПИЛОТ: ДНИ 76–90: ОЦЕНКА

Панель 12 показателей «после/до» (приложение 24; методика — раздел 22). Совет жителей формулирует позицию (протокол в отчёт учредителю). Решение директора: расширение, закрепление точки, свёртывание с фиксацией причин.

ПИЛОТ: А. ГРАНИЦЫ ДИЗАЙНА ПИЛОТА

Пилот 90 дней проверяет **исполнимость и безопасность**, не **эффективность** вариативности (раздел 27.5).

Показывает: исполнимость (два варианта, журналы, доступность выбора); грубые сигналы безопасности (отказы, аспирации); цену (сырьё, труд, отходы).

Не доказывает: причинное влияние выбора на отходы, вес, настроение (нужны контрольная группа и мощность; исследований в психиатрии нет).

Смещения: эффект новизны (Хоторна) — выводы по дням 30–90; сезонность; ротация смен — одна смена-единомышленник; возврат к среднему — база семь дней.

Критерии: расширение — журналы без срывов, выбор на большинстве приёмов, отказы не выросли, трудозатраты в смете. Свернуть — рост отказов/аспираций или неподъёмные трудозатраты (35.5).

ПИЛОТ: КРИТЕРИИ ОСТАНОВКИ

Немедленная остановка: рост отказов (раздел 12); санитарные нарушения линии (раздел 18); противопоказания врача. Остальное — корректируемые параметры.

Пилот М1 на одном отделении обычно укладывается в текущую смету; полный переход — оборудование и ставки⁵.

ПИЛОТ: ТИПОВЫЕ ИСХОДЫ

Застой: журналы не ведутся к 60-му дню — отсутствие владельца ритма. **Бунт кухни:** технологическая невыполнимость — проектирование пар завпроизводством. **Фиктивное оживление:** предзаполнение журналов — проверка реальности (приложение 24) с 15-го дня. **Свёртывание с причинами** — управленческий результат с данными.

ПИЛОТ: МАСШТАБ ТОЧКИ

Одно отделение 20–35 жителей, одна смена, один приём. Серафимовский: 1 004 проживающих (февраль 2026, раздел 25.5). Пилот на «сложном» отделении предпочтительнее «удобного».

ПИЛОТ: ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ

День 1: заказ вечером, сверка объёмов, старшая смена на линии. Дни 2–3: коррекция очереди, маркировки. Дни 4–5: срывы, замены, проверка реальности (приложение 24). День 7: планёрка по трём корзинам. Корректировки — после семи дней данных.

ПИЛОТ: СВОЯ КУХНЯ И АУТСОРСИНГ

	Своя кухня	Аутсорсинг
Дни 1–14	Приказ, замер, опрос, инструктаж, письмо	+ сверка контракта (раздел 42.3)
Изменения	Вторая гастроёмкость, журнал на линии	Поставка двух вариантов, журнал замен поставщика
Без контракта	Старт с понедельника	Сначала восемь строк ТЗ (42.7)
Действующий контракт	—	Допсоглашение или претензия
Стоп-сигналы	Отказы, санитария, врач	+ срыв варианта Б, отсутствие проб

Публичных кейсов вариативности на аутсорсинге нет. Критерии остановки — раздел 35.5.

КАРТА: ЛОГИКА КАРТЫ

Каждый квартал даёт самостоятельный результат. Сроки — ориентир для организации среднего размера (289 мест — средняя вместимость ПНИ⁷). Карта — рекомендация, не норматив.

КАРТА: КВАРТАЛ 1 (МЕСЯЦЫ 1–3)

Параллельно с пилотом (раздел 35): аудит 24 точек (раздел 22, приложения 18–21); документальный комплект (раздел 31); инструктажи (раздел 28); лекарственно-пищевая таблица и список дисфагического риска — подпись врача. **Результат:** работающий пилот, замеры, клинические риски под документами.

КАРТА: КВАРТАЛ 2 (МЕСЯЦЫ 4–6)

Расширение выбора на все приёмы в точке пилота или соседнее отделение. Пересчёт меню по статистике (раздел 21). Совет жителей (раздел 34). **Результат:** ежедневная вариативность в 1–2 отделениях, протоколы совета.

КАРТА: КВАРТАЛ 4 (МЕСЯЦЫ 10–12)

Решение о масштабировании. Обновление положения; годовой отчёт; обмен опытом^{3, 4, 6}. **Результат:** вариативность как норма организации.

КАРТА: ТИПОВЫЕ СБОИ

«Пилот застрял» — нет решения по итогам 90 дней; профилактика — дата решения в приказе.

«Ключевой человек ушёл» — профилактика — комплект и ротация ответственных (раздел 31).

«Учредитель молчит» — запрос конкретики (согласование, форма отчёта, дата заслушивания).

КАРТА: ВЕТКИ ОБЕДНЁННОГО СЦЕНАРИЯ

Нет второй гастрೋёмкости (кейс 22): предзаказ и буфет; модель лестницы как максимум инфраструктуры. **Нет ставок на помощь** (кейс 21): форматы самостоятельности; вариативность без дополнительной помощи. **Учредитель против:** замеры и документы без изменения линии; повторный разговор на следующий цикл; региональная группа (раздел 39). Обеднённый сценарий меняет темп, не направление.

КАРТА: КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

Квартал 1 — публичный старт (приказ с датами); квартал 2 — ответы раздела 38; кварталы 3–4 — промежуточные результаты (отчёт совету, коллективу).

25. Возражения и ответы

37.1. Структура раздела

Каждое возражение содержит рациональное ядро. Ответы опираются на материалы издания; при отсутствии данных это указано.

1. **«Наши жители не способны выбирать».** Часть жителей не выбирает вербально. Выбор реализуется каналами: показ, наблюдение, биография, близкие (раздел 15). Стандарт 6 Австралии с 01.11.2025³⁹. При недоступности выбора — гарантированный стандартный вариант.
2. **«Будут очереди и хаос».** Время выбора реально. Решение: заказ накануне, визуальное меню, маркировка (раздел 20). Опыт Успенского: «страхи не подтвердились»³. Замер «до/после» в пилоте.
3. **«Это дорого».** Сырьевая строка при парных эквивалентах близка к нулю (раздел 29); труд — минуты; отходы могут снижаться. Утверждение о «бесплатности» не доказано. Семь дней замера.
4. **«Санэпид не разрешит».** СанПиН 3590-20 / с 01.09.2026 — 4282-26 регулирует поточность, температуру, пробы — не число вариантов⁹. Вторая гастрорёмкость — дополнительная точка маркировки (раздел 18).
5. **«Нет диетолога».** Пары — по нутриентной логике меню-раскладки (раздел 19); клиника — врач. Опыт внедривших без диетолога^{3,4}.
6. **«Выберут нездоровое».** Выбор внутри пары эквивалентов (раздел 19), не между нормой и вредом.
7. **«Выбрал и отказался».** Журнал, альтернатива, фиксация (разделы 12, 19). США³⁴; РФ — ст. 37/43 с документированием⁸.
8. **«Лечебное питание несовместимо».** «Мост» к диетам (19РВ-32)²²; пары внутри диеты.
9. **«Персонал против».** Инструктаж, роли, планёрки; участие персонала в проектировании линии (раздел 28).
10. **«Проверка спросит».** Документальный ответ (раздел 32).
11. **«Только для малых домов».** Практики в ПНИ стандартной вместимости^{3,4}; региональное масштабирование (Иркутская область)⁶.
12. **«Зачем, если нормально?».** Семидневный замер отходов и журнал отказов.
13. **«Кухня не своя».** Вариативность — в восьми строках контракта (раздел 42). Действующий контракт без строк — допсоглашение. Публичных кейсов на аутсорсинге нет.
14. **«Новый СанПиН — не время».** 4282-26 с 01.09.2026, переходного периода нет⁹. Новый СанПиН не запрещает варианты; меняются формы бракеража (раздел 18.10, приложение 39).

37.2. Критерии аргументации

Аргумент строится как «принцип + метод проверки + измеренный факт», без морального превосходства при вопросах о ресурсах; без некритичного переноса зарубежных норм без локального расчёта; без обещаний конкретных процентов без замера (опыт³ — как ориентир, не гарантия).

37.3. Критерий «а сами бы вы так ели?»

Процедурный ответ: периодическая дегустация руководством; протоколирование дегустаций совета жителей. Строка в чек-листе директора (приложение 18).

26. Контур выше учреждения: учредитель и отрасль

УЧРЕДИТЕЛЬ: НАЗНАЧЕНИЕ СПИСКА

Решения в СОСО зависят от регионального контура: статус норм, меню, формы учёта, финансирование (раздел 24). Десять вопросов сформулированы для получения документального ответа.

УЧРЕДИТЕЛЬ: НОРМЫ И ДОКУМЕНТЫ

1. Статус норм Минтруда (приказ 520н) в регионе — рекомендация или императив?²⁹ От этого — свобода манёвра по парам (раздел 19).
2. Региональное перспективное меню СОСО — процедура внесения изменений? При императиве — сначала документ (раздел 24).
3. Акт, связывающий СОСО с лечебным питанием (образец 19РВ-32)²² — инициатива учредителя или локальный «мост»?
4. Актуальная форма учёта продуктов с учётом перехода на электронные формы⁹⁸ — допускает ли журналы заказа и замен?

УЧРЕДИТЕЛЬ: ФИНАНСЫ И ЗАКУПКИ

5. Сырьевая строка финансирования — возможность публикации учредителю и совету жителей? Прозрачность — международный ориентир^{89,93}.
6. Контракт / типовая документация — парные позиции, закупка по статистике выбора (разделы 30, 42.7)?
7. Аутсорсинг — требования к вариативности, текстуре, документированию замен (разделы 30, 42)?

УЧРЕДИТЕЛЬ: ПОЛНОМОЧИЯ И РАЗВИТИЕ

8. Согласие на пилот (раздел 35) — одна точка, 90 дней, дата заслушивания итогов.

**9. Поддержка обмена практиками^{3,4,6}.

10. Показатели качества питания — включение доли выбирающих и уровня отходов.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ПРОЦЕДУРА РАЗГОВОРА

Каждый вопрос — одностраничная справка (приложение 33). Первая повестка: вопросы 1, 2, 8. Ответы фиксируются письменно (раздел 32).

УЧРЕДИТЕЛЬ: ТИПОЛОГИЯ ОТКАЗА

Ресурс («нет денег») — нулевая стоимость, замеры, запрос под цифры. **Риск** («накажут») — документы раздела 32, замеры без изменения линии. **Статус** («не положено») — запрос нормы-основания. Отказ фиксируется письменно; не распространяется на остальные вопросы.

УЧРЕДИТЕЛЬ: СОДЕРЖАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧРЕДИТЕЛЕМ

Отчётность результатом (панель чисел); публичное указание роли учредителя^{3, 4}; передача рисков с проработанной защитой.

ОТРАСЛЬ: ПЯТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. **Минимальный стандарт выбора в рекомендованных нормах.** Приказ 520н²⁹ — нутриенты; международные системы — структура выбора (Онтарио²³, США³⁴, Австралия³⁹). Формула: не менее двух вариантов основной позиции при технологической возможности.
2. **Стык СОСО и лечебного питания.** Приказы Минздрава адресованы медорганизациям (раздел 17). Варианты: совместный акт или типовой региональный «мост»²².
3. **Два показателя отчётности:** доля участвующих в выборе; уровень отходов (приложения 24–25).
4. **Единая справка по формам учёта** при поэтапном переходе (61н, 142н, 100н, 157н, 174н)⁹⁸.
5. **Публикация практик** через методические каналы^{3, 4, 6}.

ОТРАСЛЬ: ПЯТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

6. **Статус рекомендованных норм** — рекомендация или императив (раздел 24).
7. **Процедура изменения императивного меню** с участием организаций.
8. **Региональный «мост» к лечебному питанию**²².

**9. Требования к вариативности в типовых закупках и аутсорсинговых контрактах (разделы 30, 42).

10. **Региональная площадка обмена**⁶.

ОТРАСЛЬ: СОЗНАТЕЛЬНЫЕ УМОЛЧАНИЯ

Новый федеральный закон не предлагается: рамка 3185-1, СанПиН, 520н^{8, 9, 29} достаточна; проблема — в статусах и стыках. Обязательная вариативность без ресурсов не предлагается (раздел 21). Числовые нормативы стоимости не предлагаются — данных нет.

ОТРАСЛЬ: МЕХАНИКА НОРМОТВОРЧЕСТВА

Японский пример^{99, 100}: стимулирование → данные → обязательность. Российская повестка — между фазами 1 и 2 (авангард^{2, 3, 4}, данных нет). Продуктивный запрос — показатели в отчётности (предложение 3).

27. Достоверность и ограничения

41.1. Назначение раздела

Утверждения издания различаются по силе доказательности. Ниже — классификация и границы применимости.

41.2. Четыре класса утверждений

Норма. Цитата закона или санитарного правила с реквизитами и датой проверки. Опора для разговора с юристом и проверяющим.

Толкование. Системное прочтение нормы в ситуации, которую она прямо не регулирует. Помечено в тексте; не является прямым запретом или разрешением.

Рекомендация. Опыт конкретного дома или региона. Не норма и не обещание того же эффекта.

Проект локальной формы. Шаблоны в приложениях — черновики, требующие адаптации и правовой проверки.

Слово «проверено» без даты и источника — не доказательство. «Общий опыт» — не источник.

Источники проверены 23.07.2026; правовая сверка — 19–21.08.2026. СанПиН 4282-26 — с 01.09.2026; в тексте обе редакции (3590-20 и 4282-26) с датами действия.

41.3. Пробелы доказательной базы

Репрезентативной статистики вариативного питания в российских СОСО нет. Рандомизированных исследований эффекта в психиатрических стационарах не найдено. Судебной практики о вариативном меню не обнаружено. Данных о сырьевой строке российских СОСО в публичном поле нет. Статус региональных норм не проверен индивидуально (методика — раздел 24).

41.4. Известные уязвимости

Датировка. Региональные нормы и учётные формы⁹⁸ меняются; сверка перед приказом обязательна.

Язык. Международные источники — на английском; нюансы перевода возможны.

Отбор практик. Открытый поиск; кейс 25.5 — дом автора, конфликт интересов раскрыт. Неопубликованные практики не включены.

Кейсы. Учебные разборы — по механизму, условны по фактуре.

Позиция автора. При отсутствии доказательств — аргумент с обозначенными границами (раздел 16), не норма.

28. Аутсорсинг питания: контракт как место вариативности

42.1. Назначение раздела

Питание всё чаще обеспечивает сторонняя организация¹⁰¹. Контракт определяет содержание питания; санитарная рамка не зависит от владельца плиты¹⁰¹. Публично подтверждённых кейсов вариативного меню на аутсорсинге не найдено; раздел переносит инструменты глав 19–22 и 30 в контрактную плоскость.

42.2. Правовая рамка

Закупка — 44-ФЗ¹⁰²; автономные учреждения — 223-ФЗ при наличии положения о закупке (раздел 30.1). СанПиН 4282-26: п. 56 подп. 12 — помещение для приёма готовой продукции и суточных проб (подп. 4: каждое блюдо отдельно, ≥100 г, хранение ≥48 ч при +2...+6 °С)⁹; подп. 14 — на привлекаемые предприятия⁹; раздел VI — прослеживаемость, порционирование в зоне оказания услуги⁹. До 01.09.2026 — СанПиН 3590-20, п. 7.1.11–7.1.14, раздел VI⁹. Пробы, бракераж, температура делегируются исполнением, не ответственностью перед жителями и проверяющими.

42.3. Восемь строк контракта

1. Перечень как группы взаимозаменяемых. 2. Пропорции по статистике выбора, корректировка ежеквартально. 3. Не менее двух вариантов; срыв — в журнале замен, не исполнение. 4. Замена при недопоставке — эквивалент из группы, акт. 5. Текстура (помол, консистенция) — раздел 10. 6. Приёмка, акт, пробы по п. 56 подп. 12⁹. 7. Меню-цикл, раскладка, 520н²⁹. 8. Отчётность: доля выбора, остатки — ежемесячно (раздел 22).

Негативный список: пробы — работник учреждения⁹; бракераж — акт учреждения; дисфагия — врач и пост; эскалация отказа — маршрут учреждения (раздел 12).

42.4. Контроль поставщика

Замер остатков (приложение 25); контроль линии (температура — п. 50 СанПиН 4282-26⁹; соответствие заказу; стандартный вариант); сверка проб; фотофиксация линии без персональных данных (152-ФЗ, раздел 17.6); квартальный разбор панели. Кейсы 14, 22 переносятся на аутсорсинг. Качество — ст. 6.6 КоАП¹⁰; сговоры — практика ФАС⁷⁵.

42.5. Экономика

Полная стоимость приёма — в 3–6 раз выше сырьевой строки (раздел 29, ⁵⁶). Контракт фиксирует состав порции, не только цену. Ориентиры: NHS¹⁰³; Онтарио²³.

42.7. Календарь закупки

Сентябрь: замер и журнал для спецификации (раздел 18.10). **Октябрь:** восемь строк с контрактной службой. **Ноябрь–декабрь:** строки в документации до истечения контракта или допсоглашение. **Январь:** пилот (раздел 35.9). Пропуск окна не запрещает замер; запрещает обещать выбор без договора.

Раздел читается совместно с разделами 29 (финансы) и 30 (закупки).

29. Заключение

43.1. Основные выводы

Питание в стационарной организации социального обслуживания — элемент реализации права на уважение достоинства и достаточный уровень жизни. Действующее правовое поле допускает организацию выбора: нормы существуют, серые зоны обозначены, процедуры описаны в настоящем издании. Практики внедрения зафиксированы в Успенском, Усть-Илимске, Серафимовском^{3, 4, 5} и при региональном масштабировании⁶. При аутсорсинге вариативность определяется спецификацией контракта (раздел 42).

Доказательная база неоднородна: по клинике и международным нормам — сильная; по эффекту вариативности в психиатрии — практически отсутствует (раздел 41). Следовательно, управленческий приоритет — измерение (семидневный замер, панель чисел), а не декларация.

43.2. Систематизация конфликтов

Раздел 5 фиксировал конфликты за одним столом: потребность в тишине; взаимодействие кофеина и клозапина¹⁵; дисфагия¹; невербальная воля; инерция смены. Для каждого предусмотрены процедуры: тихая зона (раздел 20); лекарственно-пищевая таблица (раздел 11); список риска и текстуры (раздел 10); каналы воли (раздел 15); документальный комплект и роли (разделы 28, 31). Конфликты не устраняются полностью, но получают управляемую процедурную форму.

43.3. Эффекты для участников процесса

Житель: участие в выборе с документированной альтернативой при отказе. **Персонал:** опорные точки — карта, текстуры, правило трёх отказов. **Директор:** система приказов, журналов, панели, взаимодействия с учредителем. **Учредитель:** полномочия по статусам норм, «мосту» к лечебному питанию, отраслевым показателям (раздел 39).

43.4. Минимальный старт

Семидневный замер отходов, отказов, времени раздачи (приложение 25) не требует согласований. С 01.09.2026 — новые формы бракеража (приложение 39); журналы августа не пересматриваются. Дальнейшие шаги определяются данными замера, а не предположениями.

Издание представляет методическую модель безопасного, достойного и вариативного питания в СОСО. Реализация — функция локальных ресурсов, регионального контура и дисциплины документирования.

30. Источники

Источники приведены в порядке первого упоминания в тексте.

1. [M-dysph_prev] Font L. et al. Дисфагия на фоне антипсихотиков: распространённость 21,9–69,5% (систематический обзор) (систематический обзор). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10455044/>
2. [S015] ГАУССО НСО «Болотнинский ПНИ»: «Вариативное питание» (16.08.2024). <https://bpni.nso.ru/news/2312> (проверено: 23.07.2026)
3. [S016] ГАУССО НСО «Успенский ПНИ»: вариативное меню во всех отделениях (13.08.2024). <https://upni.nso.ru/news/1916> (проверено: 23.07.2026)
4. [S017] ОГБУСО «Усть-Илимский дом социального обслуживания»: «Что за зверь такой? Вариативное питание» (27.09.2024). <https://ui-ogbuso.ru/novosti/> (проверено: 23.07.2026)
5. [S030] Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга: «Работа по развитию психоневрологических интернатов продолжается» (22.07.2025) — первые результаты вариативного меню в ДСО «Серафимовский». <https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/news/302216/> (проверено: 17.08.2026)
6. [S018] Иркутская область: вариативное питание в стационарных учреждениях — выбор из двух первых, вторых и гарниров (14.02.2025). <https://irkutsk.bezformata.com/listnews/variativnoe/142531226/> (проверено: 23.07.2026)
7. [S004] Исследование «Если быть точным»: «Как устроены ПНИ в России» (09.04.2026). <https://tochno.st/materials/kak-ustroeny-pni-v-rossii-issledovanie-esli-byt-tocnym> (проверено: 23.07.2026)
8. [S011] Закон РФ № 3185-1 «О психиатрической помощи...», ст. 37, 39, 43, 44. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/ (проверено: 23.07.2026)
9. [S003] СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (пост. ГГСВ РФ от 27.10.2020 № 32), п. 7.1.11–7.1.14 — до 01.09.2026; СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (пост. ГГСВ РФ от 02.06.2026 № 18, зарег. в Минюсте 02.06.2026 № 86854), п. 56 подп. 11–14, п. 62, раздел VI. https://rovenkiadm.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/SanPiN_2.4.4282-26.pdf (проверено: 17.08.2026)
10. [S012] Прокуратура: проверки питания в соцучреждениях, дела по ст. 6.6 КоАП (Кашин СРЦ 2022; Зеленогорск 2021; представление 19.03.2024 soc13.ru). <https://www.kashin.info/prokuratura-informiruet/novosti-prokuratury/9121> (проверено: 23.07.2026)
11. [S008] Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 607-п (нормы питания), актуальная ред.. https://ctonus.ru/f/normy_pitaniya.docx (проверено: 23.07.2026)
12. [S021] Постановление адм. Псковской обл. № 206; постановление Правительства Красноярского края № 607-п; пост. Правительства Ленобласти № 458; пост. Правительства ХМАО № 306-п. — (проверено: 23.07.2026)
13. [M-pillinger] Pillinger T. et al. Мета-анализ 100 РКИ (25 952 пациента): прибавка веса на антипсихотиках от –0,23 кг (галоперидол) до +3,01 кг (клозапин) за медиану 6 нед (Lancet Psychiatry, 2020) (2020). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31860457/>
14. [M-mortality] Correll C. et al. Мета-анализ смертности при шизофрении: смерть на 15–20 лет раньше; пневмония RR 7,00 — высшая из естественных причин (World Psychiatry, 2022) (2022). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9077617/>
15. [M-cloz_hagg] Hägg S. et al. Кофеин 400–1000 мг/день: +19% AUC клозапина, –14% клиренс (2000). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2014893/>
16. [M-lithium] Литий и диета: почки обрабатывают литий и натрий сходно; дефицит натрия/обезвоживание → рост уровня лития (Cleveland Clinic). <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/25207-lithium-toxicity>
17. [M-maoi_nhs] NHS. MAOI — диетические ограничения (тирамин): пациентский листок (NHS). <https://www.torbayandsouthdevon.nhs.uk/uploads/25672.pdf?last-updated=20201119>
18. [M-carb_gf] Garg S.K. et al. Грейпфрутовый сок: пик карбамазепина 6,55→9,20 мкг/мл (+40%), AUC +41% (1998). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9757152/>
19. [S032] Приказ Минздрава России от 05.08.2003 № 330н «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ» (Инструкция по организации лечебного питания, диеты по Певзнеру; действующая редакция — с изм., внесёнными приказом Минздрава России от 19.02.2024 № 70н). https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44323/ (проверено: 19.08.2026)
20. [S033] Приказ Минздрава России от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания» (действующая редакция — с изм., внесёнными приказом Минздрава России от 19.02.2024 № 70н). https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149196/ (проверено: 19.08.2026)
21. [S022] Постановление ВС РФ от 21.02.2019 № 11-АД19-4 (переквалификация 6.6→6.7 КоАП). <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72095418/> (проверено: 23.07.2026)

22. [S019] ДДСОЛ (Московская обл.): 14-дневное вариативное меню, совет по питанию, замены по желанию жителей с врачом. <https://ddsol.ru/about/pitanie/> (проверено: 23.07.2026)
23. [l-ontario] O. Reg. 246/22 (General) под Fixing Long-Term Care Act 2021, ст. 75–80 — Онтарио, Канада, 2022. <https://www.ontario.ca/laws/regulation/220246>
24. [M-dysph_rev] Дисфагия при шизофрении: механизмы (паркинсонизм, сухость, гиперсаливация, седация, нарушения еды) — обзор (обзор). <https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2024.1448623/full>
25. [M-cloz_case] Yartsev P. et al. Тяжёлая токсичность клозапина при приёме энергетиков (600 мг кофеина/день; уровень 1796 нг/мл) — клинический случай (2021). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8043221/>
26. [l-gc1] Замечание общего порядка № 1 (2014) Комитета ООН по правам инвалидов о ст. 12 КПИ (CRPD/C/GC/1) — Комитет ООН по правам инвалидов, 2014. <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-1-article-12-equal-reco>
27. [M-mortality2] Шведский регистр: ССЗ — ведущая причина избыточной смертности при шизофрении (MRR 2,80; смерть от ССЗ на 10 лет моложе) (регистровое исследование). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6137375/>
28. [l-dge_betrl] DGE-QST Betriebe/Kliniken: цикл ≥4 недель, вегетарианское ежедневно, перекусы в любое время — Германия. https://www.jobundfit.de/fileadmin/user_upload/medien/DGE-QST/DGE-Qualitaetsstandard_Betriebe_Behoerden_Hochschulen.pdf
29. [S002] Приказ Минтруда России от 13.09.2022 № 520н «Об утверждении рекомендуемых норм питания...». <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405607433/> (проверено: 23.07.2026)
30. [l-lvnat] Livsmedelsverket. Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen (ночной интервал ≤11 ч; 6 приёмов) — Швеция, 2021. https://www.livsmedelsverket.se/49bd7f/globalassets/publikationsdatabas/broschyrrer-foldrar/riktlinjer_for_maltider_aldreomsorgen.pdf
31. [l-dge] DGE-QST для стационарных учреждений (Essbiografie, Wunschkost, Fingerfood, аудит) — Германия. https://www.bmleh.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ernaehrung/GesundeErnaehrung/DGE-Standard_Seniorenverpflegung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
32. [l-fin_nnc] Suominen M. et al. Nutritional guidelines for older people (семейные трапезы, персонал ест вместе) — Финляндия, 2020. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12877505/>
33. [M-nijs] Nijs K. et al. Family-style mealtimes: cluster RCT (BMJ, 2006) (2006). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1463975/>
34. [l-cfr] 42 CFR § 483.60 Food and Nutrition Services (CMS) — США, 2016. <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/42/483.60>
35. [l-bda] BDA. Nutrition and Hydration Digest / руководство по питанию в психиатрических стационарах — British Dietetic Association. <https://www.bda.uk.com/asset/A18E6711-ODCF-4191-851AB06AC59B4C90/>
36. [l-ghouse] Green House Project: модель и независимая оценка (качество жизни, нейтральная стоимость) — США. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5338211/>
37. [l-at_qs] Qualitätsstandard Ernährung в домах престарелых (Австрия, актуализация 2022) — Sozialministerium, Австрия. https://www.sozialministerium.gv.at/dam/jcr:4f9ff5dc-a44c-4dee-b8d9-a22e6cd3c300/AKTUALISIERT_QS_f%C3%BCr_die_Ern%C3%A4hrung_in_Wohn-_und_Pflegeeinrichtungen_f%C3%BCr_Seniorinnen_und_Senioren.pdf
38. [l-cqc14] CQC. Regulation 14: Meeting nutritional and hydration needs — руководство для поставщиков — CQC, Великобритания. <https://www.cqc.org.uk/guidance-regulation/providers/regulations-service-providers-and-managers/health-social-care-act/regulation-14>
39. [l-aus6] Strengthened Aged Care Quality Standards, Standard 6 — Food and Nutrition — ACQSC, Австралия, 2025. <https://www.agedcarequality.gov.au/providers/quality-standards/strengthened-aged-care-quality-standards>
40. [M-resolve] RESOLVE: реалистский синтез антипсихотической прибавки веса (2025) (2025). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12531729/>
41. [M-dysph_dd] Дисфагия, аспирационная пневмония и кишечная непроходимость на антипсихотиках у лиц с нарушениями развития; предупреждение FDA о запорах на клозапине (2020) (обзор). <https://www.jscimedcentral.com/public/assets/articles/psychiatry-11-1183.pdf>
42. [M-iddsi2017] Cichero J.A.Y. et al. The IDDSI Framework (Dysphagia, 2017;32(2):293–314) (IDDSI, 2017). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27913916/>
43. [M-iddsi_wu] Wu X.S. et al. IDDSI implementation: соответствие текстур 44%→90% (2022). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8994209/>
44. [l-aus_iddsi] ACQSC. Texture-modified food and fluids (IDDSI, EDAR) — provider fact sheet — ACQSC, Австралия. https://www.agedcarequality.gov.au/sites/default/files/media/fnd_providers_texturemodified.pdf

45. [M-dehydr_steele] Steele C.M. Harпузка лечения загущёнными жидкостями: нет убедительных данных о снижении осложнений при доказанном снижении потребления жидкости (Breathe (ERS), 2021). <https://publications.ersnet.org/content/breathe/17/1/210003>
46. [M-dehydr_li] Li W.Q. et al. Систематический обзор и мета-анализ применения загущённых жидкостей при дисфагии (2025). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12516007/>
47. [M-guss_trapl] Trapl M. et al. GUSS (Gugging Swallowing Screen): прикроватный скрининг дисфагии, валидирован против FEES, выполняется подготовленной медсестрой (Stroke, 2007). <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.107.483933>
48. [M-eat10] Belafsky P.C. et al. EAT-10: 10-пунктный опросник симптомов дисфагии (само- и интервью-версии) (Ann Otol Rhinol Laryngol, 2008). <https://doi.org/10.1177/000348940811701210>
49. [M-oral_yoneyama] Yoneyama T. et al. Ежедневный уход за полостью рта в домах ухода: частота пневмоний 11 % против 19 % в контроле (ПКИ, 366 проживающих) (J Am Geriatr Soc, 2002). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11874491/>
50. [M-oral_muller] Müller F. Обзор 4 ПКИ: улучшение гигиены полости рта может предотвращать ~1 из 10 смертей от аспирационной пневмонии у немощных пожилых (Gerodontology, 2015). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4541086/>
51. [M-dental_porter] Porter J. et al. Более половины проживающих домов ухода сообщают о проблемах полости рта — преимущественно сухость во рту и плохо сидящие протезы (Int J Dent Hyg / PMC, 2015). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4501060/>
52. [M-cloz_wd] Отмена кофеина: снижение уровня клозапина на 37–47% (Carrillo 1998; обзор) (клинический обзор). <https://www.pharmacytimes.com/view/caffeine-and-clozapine>
53. [M-lithium_sp] StatPearls. Lithium Toxicity: риски — дегидратация, диуретики, лихорадка, потери ЖКТ (StatPearls). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499992/>
54. [M-maoi_guide] MAOI diet and tyramine: руководство для назначающих (обновление 2022) (prescriber's guide). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9172554/>
55. [M-maoi_hist] «Сырная реакция» на ИМАО: история открытия (Blackwell; АД 160/90→220/115) (исторический обзор). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2738414/>
56. [I-dcbp] Dietitians of Canada. Best Practices for Nutrition, Food Service and Dining in LTC Homes — Онтарио, 2019. <https://www.dietitians.ca/DietitiansOfCanada/media/Documents/Resources/2019-Best-Practices-for-Nutrition,-Food-Service-and-Dining-in-Long-Term-Care-LTC-Homes.pdf>
57. [M-comf_oralfeed] Oral feeding options for people with dementia: a systematic review (систематический обзор (2011); PMID 21391936). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21391936/>
58. [M-comf_jnha] Comfort feeding in hospitalised people with dementia: a retrospective study of survival following comfort feeding recommendations (J Nutr Health Aging, 2024; DOI 10.1016/j.jnha.2024.100362). <https://doi.org/10.1016/j.jnha.2024.100362>
59. [M-crwg] Мета-анализ CRWG (прибавка ≥7% за 38 нед): клозапин 76,3%, оланзапин 36,9%, рисперидон 23,0% (BJPsych Open, January 2023, DOI 10.1192/bjo.2022.619). Campforts 2026 — другая статья (семаглутид/метформин). (2023). <https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-open/article/association-between-antipsychotic-medication-and-clinically-relevant-weight-change-metaanalysis/C2DC78D062978D7C805E0E9B99B7911F>
60. [M-fepwg] Мета-анализ при первом эпизоде психоза: долгосрочно оланзапин +9,34 кг, клозапин +7,19 кг (мета-анализ). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5589463/>
61. [M-metmon] Мониторинг метаболического риска на антипсихотиках: график (вес/ИМТ: исходно, 4/8/12 нед, 6 мес, ежегодно; глюкоза/липиды/АД: исходно, 12 нед, ежегодно) (клинические рекомендации). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8582768/>
62. [M-lifestyle] Lifestyle interventions in mental health conditions: systematic review (57 исследований; −1,42 кг) (2022). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9462072/>
63. [M-teasdale] Teasdale S. et al. Nutrition/dietary interventions for SMI (MJA, 2023) (2023). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9828433/>
64. [M-must_bapen] BAPEN. MUST — Malnutrition Universal Screening Tool: 5-шаговый скрининг (ИМТ, непреднамеренная потеря >5 % за 3–6 мес, острое заболевание); для домов ухода — регулярное (обычно ежемесячное) взвешивание (BAPEN, Великобритания, 2003/2018). https://www.bapen.org.uk/pdfs/must/must_explan.pdf
65. [M-constip_ep] Every-Palmer S. et al. Клозапин-индуцированная гипомотильность ЖКТ: запоры у 30–60 % пациентов, при объективных методах — до 80 %; тяжёлый запор может быть фатальным (иблиус, перфорация) (Aust N Z J Psychiatry / PMC, 2017). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5533872/>
66. [M-constip_nhs] NHS Specialist Pharmacy Service. Ведение запоров у принимающих клозапин: может быть фатальным; мониторинг стула, профилактические слабительные (NHS, Великобритания). <https://sps.nhs.uk/articles/managing-constipation-in-people-taking-clozapine/>

67. [M-micro_psys] Cuomo A. et al. Дефицит витамина D распространён в психиатрической популяции; рекомендован рутинный скрининг (Frontiers in Psychiatry, 2019). <https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2019.00167/full>
68. [M-micro_vitd] LoPinto-Khoury C. et al. Мета-анализ: карбамазепин ассоциирован со снижением 25(OH)D (Epilepsy Research, 2021). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34847425/>
69. [M-micro_b12] Hanna S. Дефицит В12 и фолата у пожилых: связь с депрессией и когнитивными нарушениями, недодиагностика (Primary Care Companion / PMC, 2009). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2781043/>
70. [M-montessori] Montessori-based interventions for dementia: systematic review (15 исследований) (2023). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10336713/>
71. [I-orebro] Örebro kommun. Riktlinjer för mat, måltid och nutrition (IDDSI, процесс нутритивной помощи) — Швеция, 2023. <https://www.orebro.se/download/18.5779588418bcc1d3d2313d8/1700215055156/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20mat,%20m%C3%A5ltider%20och%20nutrition%20version%206,%2023-11-16.pdf>
72. [S001] ФЗ № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», ст. 9, 16, 17, 31, 32. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ (проверено: 23.07.2026)
73. [S024] Лозовская С.О. «Правосубъектность лиц, признанных недееспособными и ограниченно дееспособными вследствие психического расстройства». <https://vestnik.msa.ru/jour/article/view/2058> (проверено: 23.07.2026)
74. [S009] Ст. 31 442-ФЗ + ПП РФ № 1075 (расчёт среднедушевого дохода). https://www.consultant.ru/law/podborki/plata_za_stacionarnoe_socialnoe_obslyuzhivanie/ (проверено: 23.07.2026)
75. [S013] ФАС: картель на торгах поставки соц. значимых продуктов, 543 торга, 4,7 млрд руб. (25.07.2024, РФ). <https://rg.ru/2024/07/25/fas-raskryla-kartel-na-torgah-na-postavku-socialno-znachimyh-produktov.html> (проверено: 23.07.2026)
76. [S014] ФАС/ФСБ: картель на школьном питании Челябинск, 27 тендеров 2022–2024, штраф 5,1 млн (01.08.2025). <https://www.pro-goszakaz.ru/news/116068> (проверено: 23.07.2026)
77. [I-crpd28] КПИ, ст. 28 «Адекватный жизненный уровень и социальная защита» — ООН. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities>
78. [I-pioneer] Pioneer Network. Home-Style Dining Interventions — США. <http://www.pioneernetwork.org/wp-content/uploads/2016/10/Home-Style-Dining-Interventions.pdf>
79. [I-eden] Eden Alternative: философия и десять принципов — США. <https://edenalt.org/>
80. [I-tallg] Region Jämtland: кейс Tallgläntan — замеры ночного голодания 2х/год — Швеция, 2016. <https://www.regionjh.se/download/18.7b79416a31d3449611c4/1557149809111/2016-2-Skogglind-%C3%96hman.pdf>
81. [S010] Письмо Минтруда о семинаре + список участников (приложения пользователя). — (проверено: 23.07.2026)
82. [S005] Ведомости: «Психоневрологических интернатов за три года стало на 13% меньше» (10.04.2026). <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2026/04/10/1189295-psihonevrologicheskikh-internatov-stalo-menshe> (проверено: 23.07.2026)
83. [S020] Постановление Правительства Москвы № 1068-ПП (нормы питания в стационарных организациях). — (проверено: 23.07.2026)
84. [S035] Приказ директора СПб ГАСУСОН «ДСО «Серафимовский» от 10.03.2026 № 124 «Об утверждении правил внутреннего распорядка жителей СПб ГАСУСОН «ДСО «Серафимовский»» (в правилах закреплено заказное питание — вариативное меню, в т. ч. для маломобильных граждан; PDF опубликован на архив сайта: web.archive.org/web/20260415001233/https://www.pni9.ru/правила-внутреннего-распорядка/). (проверено: None)
85. [I-bda_res] BDA. Практические ресурсы по питанию в психиатрии (лекарственно-пищевые взаимодействия) — BDA. <https://www.bda.uk.com/practice-and-education/resources-for-practice/mental-health-learning-disability-inpatients.html>
86. [M-pm_rev] Porter J. et al. Protected mealtimes: systematic review & meta-analysis (Int J Nurs Stud, 2017) (2017). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27866011/>
87. [M-pm_rct] Porter J. et al. Protected Mealtimes: stepped-wedge cluster trial (2019) (2019). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5295189/>
88. [I-hugo] Hugo C. et al. What does it cost to feed aged care residents in Australia? (Nutrition & Dietetics, 2018) — Австралия, 2018. https://pure.bond.edu.au/ws/files/25958488/What_does_it_cost_to_feed_aged_care_residents_in_Australia.pdf
89. [I-fct] Milte R. et al. Foodservice Costing Tool study (2022): полная стоимость пищевой службы; надбавка \$10 — Ун-т Квинсленда, 2022. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9321358/>
90. [I-ftag] The Consumer Voice. Food Appendix (F-теги пищевого блока) — США. <https://theconsumervoice.org/wp-content/uploads/2026/06/Food-Appendix.pdf>

91. [l-jperia] ERIA. Outcomes of Long-term Care in Japan (доплаты и исходы, HR 0,90) — Япония, 2020. <https://www.eria.org/uploads/media/Research-Project-Report/2020-13-Outcomes-of-Long-term-Care-Japan/Outcome-of-Long-term-Care-Insurance-Service-in-Japan-new.pdf>
92. [l-jpdiet] Больше диетологов в штате дома → ниже риск потенциально предотвратимых госпитализаций: скоррект. HR 0,72 (95% ДИ 0,54–0,97); ретроспективная когорта 2909 жителей 235 домов — BMC Geriatrics (Ибараки, Япония), 2023; ст. 566; DOI 10.1186/s12877-023-04278-2. <https://doi.org/10.1186/s12877-023-04278-2>
93. [l-ont_fao] FAO Ontario: финансирование LTC, конверт raw food — Онтарио, 2019. <https://fao-on.org/wp-content/uploads/2024/08/Long-term-care-homes-program.pdf>
94. [l-torstar] Toronto Star: конверт сырья \$8,33 CAD (2017) — Онтарио, 2017. https://www.thestar.com/news/canada/ontario-nursing-homes-feed-seniors-on-8-33-a-day/article_6b7fab43-437c-5ba6-bbfb-0f1d6426062b.html
95. [l-anfp] ANFP Benchmarking Program: расходы на сырьё в nursing homes — США. <https://www.anfponline.org/docs/default-source/legacy-docs/docs/benchmarking-program/anfpbenchmarkingprogramarticle-marchapril2018.pdf>
96. [l-snn] Skilled Nursing News: >25% домов снизили расходы на питание ниже \$10 (2025) — США, 2025. <https://skillednursingnews.com/2025/04/more-than-25-of-nursing-homes-slash-food-spending-below-10-a-day/>
97. [l-m3mmar] M3 (Making the Most of Mealtimes): адекватность меню и потребление (mMAR) — Канада. <https://www.jnursinghomeresearch.com/1592-food-services-in-long-term-care-homes-are-associated-with-residents-food-intake.html>
98. [S006] Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н: статус на 2026 г.. <https://base.garant.ru/58070703/> (проверено: 23.07.2026)
99. [l-jp2005] NIPH Journal: реформа LTCI 2005 и пищевые доплаты — Япония, 2006. <https://www.niph.go.jp/journal/data/55-1/200655010006.pdf>
100. [l-jp2021] Ревизия тарифов 2021: усиленная доплата, обязательный стандарт, вычет, LIFE — MHLW, Япония. <https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2021housyuukaitei/documents/eiyoucaremanezimentonozyuuzitu.pdf>
101. [S025] «Кейтеринг в организациях социального обслуживания» (отраслевое издание, 2022). https://www.profiz.ru/sec/4_2022/Kejtering/ (проверено: 23.07.2026)
102. [S023] ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (проверено: 23.07.2026)
103. [l-nhs2016] Hospital Food Standards Panel. Standards for food and drink in NHS hospitals — ДН, Великобритания, 2016. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a806e1eed915d74e33fa61a/Hospital_Food_Panel_May_2016.pdf